Perfil V3 · código por código

Salud Pública

Los 55 códigos del Perfil de Conocimientos EUNACOM v3 (2026) de Salud Pública, uno por uno: el nivel que exige el examen, dónde se enseña en nuestros libros, lo que hay que saber en resumen y una pregunta.

Niveles del Perfil — Diagnóstico: **Sospecha** (reconocer y derivar) o **Específico** (confirmar). Tratamiento: **Inicial** (estabilizar y derivar) o **Completo**. Seguimiento: **Derivar**, **Completo** o **No requiere**.

Conocimientos generales 55 códigos

7.01.3.001 Conceptos y definiciones de Salud Pública

Dónde se enseña: Tema 21.5 Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

QUÉ HAY QUE SABER

- Salud pública (Winslow): ciencia y arte de prevenir la enfermedad, prolongar la vida y promover la salud mediante el esfuerzo organizado de la sociedad; su sujeto es la población, no el individuo.
- Salud: bienestar físico, mental y social, no solo ausencia de enfermedad (OMS). Incluye determinantes sociales, promoción, prevención, organización de servicios y rehabilitación; no se limita al sector estatal ni a las infecciones.
- MAIS (Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria): centrado en las personas, integral (promoción a cuidados paliativos) y con continuidad del cuidado por un equipo de cabecera; la unidad de trabajo es la familia y la comunidad.
- Instrumentos del MAIS: genograma (estructura familiar, ≥3 generaciones), ecomapa (redes de apoyo y aislamiento), APGAR familiar (7-10 normal, 4-6 disfunción leve a moderada, 0-3 severa).
- Diagnóstico de situación de salud (ASIS) del territorio del CESFAM: datos objetivos + diagnóstico participativo con la comunidad, luego priorización y plan de acción.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un médico recién llegado a una Dirección de Salud comunal pregunta en qué se diferencia su nuevo trabajo de la atención clínica que realizaba en el hospital. **¿Qué característica define mejor a la salud pública?**

A) Su objeto es el diagnóstico y tratamiento de cada paciente individual
B) Su objeto es la salud de la población, mediante esfuerzos organizados de la sociedad
C) Es la medicina ejercida exclusivamente en establecimientos estatales
D) Se limita al control de enfermedades infecciosas
E) Se ocupa principalmente de la gestión hospitalaria

Respuesta B. La salud pública es la ciencia y el arte de prevenir la enfermedad, prolongar la vida y promover la salud mediante esfuerzos organizados de la sociedad (Winslow). Su sujeto es la población, no el individuo, e incluye determinantes sociales, promoción, prevención y organización de servicios. No se restringe al sector estatal ni a las infecciones.

7.01.3.002 Funciones esenciales de la Salud Pública

Dónde se enseña: Tema 21.1 Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

QUÉ HAY QUE SABER

- Funciones esenciales de salud pública (FESP, OPS): acciones colectivas que el Estado debe garantizar; no son prestaciones clínicas individuales.
- Incluyen monitoreo y análisis de la situación de salud, vigilancia y control de riesgos y daños, promoción de la salud, participación social, políticas y regulación, acceso equitativo a servicios, desarrollo del recurso humano, calidad, investigación y gestión de emergencias.
- En Chile la rectoría (políticas, normas) es del MINSAL con sus subsecretarías (Salud Pública: vigilancia y SEREMI; Redes Asistenciales: Servicios de Salud); la Superintendencia de Salud fiscaliza (autónoma) y el ISP es el laboratorio nacional de referencia.
- Clave de examen: distinguir quién norma (MINSAL), quién administra la red (Servicios de Salud), quién fiscaliza (Superintendencia) y quién financia/asegura (FONASA).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

La Organización Panamericana de la Salud definió las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP), que son responsabilidad indelegable del Estado y permiten evaluar el desempeño de la autoridad sanitaria. **¿Cuál de las siguientes corresponde a una Función Esencial de Salud Pública?**

A) Comercialización de seguros de salud
B) Realización de cirugías electivas en clínicas privadas
C) Monitoreo, evaluación y análisis de la situación de salud de la población
D) Fabricación de medicamentos genéricos
E) Atención odontológica estética

Respuesta C. Las FESP describen las acciones colectivas que el Estado debe garantizar: monitoreo y análisis de la situación de salud, vigilancia y control de riesgos, promoción de la salud, participación social, políticas y regulación, acceso equitativo, desarrollo del recurso humano, calidad, investigación y gestión de emergencias. Las prestaciones individuales comerciales no forman parte de ellas.

7.01.3.003 Historia natural de la enfermedad

Dónde se enseña: Tema 21.10 Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos

QUÉ HAY QUE SABER

- Historia natural de la enfermedad (Leavell y Clark): período prepatogénico (agente, huésped y ambiente antes de la enfermedad) y patogénico (fase subclínica y luego clínica, con desenlace: curación, secuela, cronicidad o muerte).
- Período de latencia o fase preclínica: la enfermedad ya existe sin síntomas; es la ventana que aprovecha el tamizaje.
- Cada período se asocia a un nivel de prevención: prepatogénico a prevención primaria (promoción, protección específica); subclínico a secundaria (detección precoz); clínico tardío a terciaria (rehabilitación, limitar secuelas).
- Ejemplo: Papanicolaou que detecta lesión de alto grado en mujer asintomática = intervención en fase subclínica (prevención secundaria); la vacuna VPH actúa en el período prepatogénico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mediante el Papanicolau de tamizaje se detecta una lesión intraepitelial de alto grado en una mujer de 32 años completamente asintomática, que luego es tratada con conización. **Según el modelo de Leavell y Clark, ¿en qué período de la historia natural de la enfermedad se intervino?**

A) Período prepatogénico
B) Período de secuelas o resultado final
C) Período patogénico clínico, con síntomas
D) Período patogénico subclínico o presintomático
E) Período de convalecencia

Respuesta D. La historia natural de la enfermedad distingue un período prepatogénico (agente, huésped y ambiente antes del inicio) y uno patogénico, subclínico y luego clínico. El tamizaje detecta la enfermedad en la fase subclínica, cuando ya existe pero no da síntomas: es prevención secundaria. La vacuna contra VPH actuaría en el período prepatogénico (prevención primaria).

7.01.3.004 Niveles de prevención

Dónde se enseña: Tema 21.10 Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos

QUÉ HAY QUE SABER

- Prevención primaria: evita que aparezca la enfermedad; incluye promoción de la salud y protección específica (vacunas, cloración del agua, uso de casco, saneamiento).
- Prevención secundaria: detección y tratamiento precoz en fase preclínica (tamizaje: Papanicolaou, mamografía, tamizaje neonatal de fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito, control de presión arterial).
- Prevención terciaria: limita daño y secuelas de la enfermedad ya establecida (rehabilitación, control de diabéticos para evitar complicaciones).
- La promoción de la salud (Carta de Ottawa) da a la población los medios para controlar sus determinantes, sin dirigirse a una enfermedad específica (ciclovías, ferias saludables, entornos saludables).

- Trampa frecuente: el tamizaje es prevención secundaria; no evita la enfermedad, la detecta antes de los síntomas.

PREGUNTAS (10)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 176

¿A qué tipo de medida corresponde el tamizaje de TSH y fenilcetonuria que se hace a todos los recién nacidos en Chile? **¿Qué tipo de medida es?**

A) Promoción de la salud
B) Prevención específica
C) Prevención primaria
D) Prevención secundaria
E) Prevención terciaria

Respuesta D. El tamizaje detecta una enfermedad que ya existe, antes de que dé síntomas: es prevención secundaria.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 72

Screening de fenilcetonuria que se hace a todos los recién nacidos en Chile. **¿A qué tipo de medida corresponde?**

A) Promoción de la salud
B) Protección de la salud
C) Prevención primaria
D) Prevención secundaria
E) Prevención terciaria

Respuesta D. Un tamizaje detecta una enfermedad que ya está presente, antes de que dé síntomas: eso es prevención secundaria. La prevención primaria evitaría que la enfermedad apareciera; aquí la enfermedad ya existe, solo se adelanta el diagnóstico.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 72

Se pregunta a qué tipo de medida corresponde el tamizaje de fenilcetonuria que se hace a todos los recién nacidos en Chile. **¿A qué tipo de medida corresponde este tamizaje?**

A) Promoción de la salud
B) Protección de la salud
C) Prevención primaria
D) Prevención secundaria
E) Prevención terciaria

Respuesta D. Las pruebas de tamizaje, como la fenilcetonuria neonatal, son prevención secundaria: detectan una enfermedad que ya existe, en su fase preclínica, antes de que produzca síntomas, para tratarla precozmente. No la evitan, como haría la prevención primaria, ni tratan sus secuelas, como la terciaria.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 143 · texto original del banco, sin revisar

¿A qué concepto corresponde la siguiente definición: “Conjunto de medidas destinadas a evitar que una enfermedad ocurra, actuando antes de que exista la enfermedad o el daño causado por esta”?

A) Prevención primaria
B) Prevención secundaria
C) Prevención terciaria
D) Prevención cuaternaria
E) Promoción de la salud

Respuesta A. Prevención primaria actúa antes de que exista la enfermedad (ej. vacunas con papiloma). Prevención secundaria actúa cuando ya existe la enfermedad, pero todavía no hay síntomas, permitiendo un diagnóstico oportuno (ej. PAP). Prevención terciaria actúa cuando la enfermedad ya Gene síntomas, para recuperar la salud y evitar complicaciones y recidivas (ej. histerectomía radical). Prevención cuaternar

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 69 · texto original del banco, sin revisar

¿A qué tipo de medidas corresponde la instalación de las salas IRA (Infecciones Respiratorias Agudas) y salas ERA (Enfermedades Respiratorias del Adulto), durante las campañas de invierno, por parte del Ministerio de Salud?

A) Prevención primaria
B) Prevención secundaria
C) Prevención terciaria
D) Promoción de la salud
E) Prevención específica

Respuesta C. La enfermedad ya está presente y los pacientes ya tienen síntomas, así que es una medida de prevención terciaria. La primaria es antes de la enfermedad. La secundaria es antes de los síntomas.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 170 · texto original del banco, sin revisar

Desde el año 2005 existe la ley que obliga a los automovilistas a utilizar el cinturón de seguridad con el objetivo de disminuir traumatismos asociados a accidentes. Con respecto a esta ley, en términos de prevención, corresponde a:

A) Prevención primaria
B) Promoción de salud
C) Prevención secundaria
D) Prevención tercearia
E) Control sanitario

Respuesta A. Diagnóstico: Prevención primaria (opción A). Previene traumatismos.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 21 · texto original del banco, sin revisar

Acude a control una paciente de 26 años, trae el resultado de su papanicolau que es informado como “muestra satisfactoria, sin atipías”. ¿A qué tipo de prevención corresponde este examen?

A) Prevención específica
B) Promoción de salud
C) Prevención secundaria
D) Prevención tercearia
E) Prevención primaria

Respuesta C. El PAP hace Dg precoz, para tratamiento oportuno. Por tanto es secundaria. La vacunación contra el VPH sí es primaria.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 167 · texto original del banco, sin revisar

¿A que tipo de medida corresponde la vacunación contra una enfermedad, en la historia natural de una enfermedad?

A) Promoción de salud
B) Protección específica
C) Erradicación de la enfermedad
D) Diagnóstico oportuno
E) Tratamiento precoz

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Protección específica). Es una medida clásica de prevención primaria, de tipo prevención específica.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 11 · texto original del banco, sin revisar

¿Cuál de las siguientes medidas es más eficaz, en el mediano plazo, para disminuir la cantidad de pacientes diabéticos que progresan a necesitar hemodiálisis?

A) Screening de glicemia en población de riesgo de diabetes
B) Screening de glicemia en población adulta
C) Tratamiento eficaz en pacientes diabéticos diagnosticados
D) Prevención de factores de riesgo cardiovascular en la población adulta
E) Prevención de obesidad en la población de riesgo de diabetes

Respuesta C. Es una pregunta muy rara y muy mala, pero la única respuesta aceptable es la C, ya que es la única medida de prevención terciaria y es la forma en que se plantea la pregunta (evitar complicaciones). La A y B son prevención secundaria. La D y E son prevención primaria.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 127 · texto original del banco, sin revisar

Paciente EPOC TBQ activo, con disnea, se va a hacer un EMPA y la enfermera le hace consejería para que deje de fumar para que mejore la disnea ¿Que tipo de prevención es?

A) Prevención 1°
B) Prevención 2° c. Prevención 3°
D) Promoción de la salud (esta Era prevencion terciaria) segun yo era promocion porque igual depende del caballero si deja de fumar o no entonces no es un acto preventivo perse - Eso mismo e. Prevención 4 Pero da la razon de consejeria, es para mejorar disnea de enfermedad que ya tiene. Era prevencion terciaria porque el paciente ya estaba sintomatico, en fase de rehab.
D) Ninguna de las anteriores es correcta
E) Todas las anteriores son correctas

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Prevención 1°). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Prevención 2° c. Prevención 3°, Promoción de la salud (esta Era prevencion te) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan c

7.01.3.005 Promoción de salud y prevención de enfermedades

Dónde se enseña: Tema 21.5 Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

QUÉ HAY QUE SABER

- Promoción de la salud (Carta de Ottawa): proceso que capacita a las personas y comunidades para aumentar el control sobre su salud y sus determinantes; actúa con participación social y entornos saludables, sin focalizarse en una enfermedad.
- Prevención de enfermedades: acciones dirigidas a evitar una enfermedad específica (primaria), detectarla precozmente (secundaria) o limitar secuelas (terciaria).
- Ejemplos chilenos: Elige Vivir Sano, Chile Crece Contigo, Examen de Medicina Preventiva (EMP/EMPAM), Programa Nacional de Inmunizaciones, ley de etiquetado de alimentos y regulación del tabaco.
- Pregunta tipo: municipio que construye ciclovías, plazas activas y ferias saludables = estrategia de promoción de la salud, no prevención primaria específica.
- El médico general en APS integra ambas: consejería breve, EMP, vacunación y derivación a programas comunitarios.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un municipio, junto a vecinos y organizaciones sociales, construye ciclovías y plazas activas, y establece ferias libres con alimentos saludables a bajo costo, para mejorar la calidad de vida de toda la población comunal. **¿A qué tipo de estrategia corresponde esta iniciativa?**

A) Prevención cuaternaria
B) Prevención primaria específica
C) Prevención secundaria
D) Prevención terciaria
E) Promoción de la salud

Respuesta E. La promoción de la salud (Carta de Ottawa) busca dar a la población los medios para mejorar su salud y controlar sus determinantes, con participación social y entornos saludables, sin dirigirse a una enfermedad específica. La prevención primaria apunta a evitar una enfermedad determinada (por ejemplo, vacunar), la secundaria a detectarla precozmente y la terciaria a limitar secuelas.

7.01.3.006 Determinantes del nivel de salud

Dónde se enseña: Tema 21.5 Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

QUÉ HAY QUE SABER

- Determinantes sociales de la salud (OMS): condiciones en que las personas nacen, crecen, trabajan y envejecen; explican gran parte de las inequidades en salud.
- Estructurales (posición socioeconómica: educación, ingreso, ocupación, género, etnia) pesan más que el acceso a servicios; el nivel educacional es el de mayor impacto en mortalidad y esperanza de vida.

- Intermedios: condiciones materiales (vivienda, trabajo), factores conductuales y biológicos, cohesión social y sistema de salud.
- Modelo de Lalonde: estilo de vida y conducta, biología humana, medio ambiente y organización de la atención sanitaria; el estilo de vida es el de mayor peso.
- Implicancia: la reducción de inequidades requiere políticas intersectoriales (educación, vivienda, empleo), no solo más servicios clínicos.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 51

Según la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, se analizan distintos factores que influyen en la salud de la población. **¿Cuál de los siguientes factores tiene mayor impacto en la salud de la población?**

A) Nivel educacional
B) Vivienda
C) Alimentación
D) Ingreso económico
E) Acceso a servicios de salud

Respuesta A. Los determinantes estructurales (posición socioeconómica: educación, ingreso, ocupación) pesan más que el acceso a servicios de salud. El nivel educacional se considera el de mayor impacto, porque condiciona el ingreso, el empleo, las conductas y el uso de servicios, y se asocia de forma consistente con mortalidad y esperanza de vida.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 69 · texto original del banco, sin revisar

¿Cuál de las siguientes enfermedades corresponde con mayor probabilidad a una enfermedad laboral?

A) Dermatitis de contacto alérgica
B) Asma
C) Mesotelioma
D) Síndrome del manguito rotador
E) Trastorno adaptativo

Respuesta C. Los mesoteliomas son por exposición a asbesto. De todos modos, es una pregunta muy específica y además la frecuencia de mesoteliomas es muy baja en la actualidad (cerraron la empresa Pizarreño hace muchos años: era la que hacía placas de asbesto).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 116 · texto original del banco, sin revisar

En un gráfico de salud pública se observa que la tasa de mortalidad infantil ha disminuido progresivamente en los últimos 40 años en Chile. ¿Cuál es el principal determinante de esta tendencia?

A) Mejoras en condiciones socioeconómicas, educación materna y acceso a agua potable
B) Introducción de nuevos antibióticos
C) Vacunación masiva universal
D) Aumento del número de médicos
E) Disminución de la natalidad

Respuesta A. La caída histórica de la mortalidad infantil se atribuye principalmente a determinantes sociales: mejor nivel educacional, condiciones sanitarias, acceso a agua potable y saneamiento, más que a intervenciones médicas aisladas.

7.01.3.007 Demografía y salud pública

Dónde se enseña: sp-15

QUÉ HAY QUE SABER

- Demografía: estudia tamaño, estructura y dinámica de la población (natalidad, mortalidad, migración); fuentes: Censo, estadísticas vitales (nacimientos y defunciones del Registro Civil/DEIS) y encuestas.
- Pirámide poblacional: base ancha = población joven y alta natalidad; base estrecha y cima ancha = envejecimiento. Chile está en transición demográfica avanzada, con baja natalidad y fecundidad bajo el nivel de reemplazo.
- Transición epidemiológica: predominio de enfermedades crónicas no transmisibles y cáncer sobre infecciosas, con aumento de la carga en adultos mayores y de la dependencia.
- Índices útiles: índice de envejecimiento (≥65 años por 100 menores de 15), razón de dependencia, tasa bruta de natalidad y de mortalidad, esperanza de vida al nacer.
- Uso en salud pública: dimensionar demanda por grupo etario, planificar la red asistencial y calcular tasas ajustadas por edad para comparar poblaciones.

PREGUNTAS (8)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 138

Si aumenta la velocidad de envejecimiento en la población que pasara en temas de salud publica: **¿Qué ocurre?**

A) Aumento de cobertura de adultos mayores en APS
B) Aumento de personas con fragilidad
C) Aumento en la variabilidad de morbilidad o mortalidad
D) Ninguna de las anteriores es correcta
E) Todas las anteriores son correctas

Respuesta B. Un envejecimiento poblacional más rápido aumenta el número de personas mayores con pérdida de reserva funcional, es decir, con fragilidad. Por eso el EMPAM busca pesquisarla de forma sistemática en APS.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 13

Una localidad de la zona norte del país experimenta un aumento significativo de migrantes debido a un programa de incentivos laborales y subsidios económicos, el cual exige una permanencia mínima de 5 años y atrae principalmente a parejas jóvenes y niños. **¿Cuál de los siguientes cambios demográficos es esperable?**

A) Aumento de la expectativa de vida de la población
B) Aumento de la tasa bruta de mortalidad
C) Aumento de la tasa bruta de natalidad
D) Aumento de la tasa de mortalidad infantil
E) Aumento de la prevalencia de cánceres ginecológicos

Respuesta C. La llegada de población joven en edad reproductiva rejuvenece la estructura por edad: aumentan los nacimientos respecto de la población total, elevando la tasa bruta de natalidad, y tiende a bajar la tasa bruta de mortalidad. La esperanza de vida y la mortalidad infantil dependen de las condiciones de vida y atención, no de la estructura etaria.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 12 · texto original del banco, sin revisar

En una zona rural del país se recibe una gran cantidad de migrantes, principalmente personas jóvenes y sanas. Desde el punto de vista de la gestión en salud pública para dicha zona, ¿qué medida debe priorizarse?

A) Aumentar los recursos para el programa de enfermedades crónicas
B) Aumentar los recursos para los programas de atención materno-infan2l
C) Reforzar los programas de saneamiento básico
D) Realizar empadronamiento de los migrantes
E) Aumentar el número de camas hospitalarias

Respuesta B. La inmigración de personas sanas y en edad fértil (fenómeno que ha ocurrido en Chile en la última década), produce aumento de la tasa de natalidad, por lo que es necesario destinar mayores recursos a la atención materno infantil. La población usuaria sí aumenta, por lo que muchas veces sí es necesario aumentar la capacidad de atención (ej. personal o camas), pero, al ser sanas, suele ser menor est

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 124 · texto original del banco, sin revisar

Un país presenta la siguiente pirámide poblacional: ¿En qué tipo de medidas se deben focalizar las intervenciones de salud pública?

A) Prevenir y tratar oportunamente el cáncer
B) Prevención del consumo de drogas, cigarrillo y alcohol
C) Planificación familiar, prevención de la desnutrición, saneamiento básico y vacunación
D) Fomentar la actividad física y prevenir el sedentarismo y la obesidad
E) Detección y tratamiento oportuno de enfermedades crónicas no transmisibles

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Planificación familiar, prevención de la desnutrición, saneamiento básico y vacunación). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 153 · texto original del banco, sin revisar

¿Cuál de los siguientes indicadores es una variable de la demografía dinámica?

A) Tasa de fecundidad
B) Índice de población urbana / rural
C) Tasa de masculinidad
D) Distribución etárea
E) Tasa de mortalidad infantil

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Tasa de fecundidad). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Índice de población urbana / rural, Tasa de masculinidad) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentació

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 1 · texto original del banco, sin revisar

¿Cuál corresponde a un indicador de demografía dinámica?

A) Tasa de mortalidad infantil
B) Tasa de prevalencia de diabetes
C) Índice de masa corporal poblacional
D) Tasa de alfabetismo
E) Porcentaje de cobertura vacunal

Respuesta A. Diagnóstico: Tasa de mortalidad infantil (opción A). Tasa de mortalidad infantil. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 7 · texto original del banco, sin revisar

Se tiene una población con pirámide poblacional de base ancha y vértice angosto. ¿En qué tipo de medidas debe enfocarse la salud pública?

A) Manejo de enfermedades crónicas y oncológicas
B) Planificación familiar, saneamiento básico y vacunación
C) Rehabilitación y cuidados paliativos
D) Prevención cardiovascular en adultos mayores
E) Tamizaje de cáncer en adultos

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Planificación familiar, saneamiento básico y vacunación). Planificación familiar, saneamiento básico y vacunación. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 4 · texto original del banco, sin revisar

Una población presenta la siguiente pirámide poblacional: ¿En qué tipo de medidas deben enfocarse sus políticas de salud pública?

A) Prevención y manejo de patologías crónicas no transmisibles
B) Prevención y tratamiento de patologías de salud mental
C) Saneamiento básico, planificación familiar y vacunación
D) Prevención de tabaquismo, alcoholismo y consumo de drogas
E) Promoción de actividad física y alimentación saludable

Respuesta C. Es una pirámide joven, por lo que debe enfocarse en salud maternoinfantil, nutrición y control de patologías infecciosas. Todas las demás opciones son importantes en las pirámides de transición y envejecidas, en especial el manejo y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT).

`7.01.3.008` Diagnóstico de situación de salud:

Dónde se enseña: Tema 21.5 Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico de situación de salud (ASIS): caracteriza el perfil epidemiológico, sociodemográfico y de determinantes sociales de la población de un territorio (p. ej. la inscrita en un CESFAM).
- Debe ser participativo: combina datos cuantitativos (demografía, morbimortalidad, factores de riesgo, recursos) con la percepción de la comunidad (junta de vecinos, consejos locales).
- Culmina en la priorización de problemas y la programación de acciones, y se actualiza periódicamente.
- Es el insumo del plan de salud comunal y de la planificación del equipo de cabecera.

- No confundir con ecomapa/genograma/APGAR (instrumentos de familia) ni con el estudio de brote (evento puntual).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

El equipo de un CESFAM urbano, con 32.000 inscritos, necesita planificar sus actividades del próximo año. Para ello quiere caracterizar el perfil epidemiológico, sociodemográfico y de determinantes sociales de toda la población de su territorio, usando censos, estadísticas vitales y registros del establecimiento, e incorporando la opinión de la comunidad. **¿Cómo se denomina este proceso?**

A) Diagnóstico o análisis de situación de salud
B) Estudio de brote
C) Ecomapa comunitario
D) Vigilancia epidemiológica centinela
E) Auditoría clínica

Respuesta A. El diagnóstico o análisis de situación de salud (ASIS) caracteriza la salud de una población de un territorio y sus determinantes, con datos objetivos y participación comunitaria, para priorizar problemas y planificar. El ecomapa evalúa a una familia, no a una comunidad, y el estudio de brote investiga un evento puntual.

7.01.3.009 Indicadores de nivel de salud: cálculo e interpretación

Dónde se enseña: Tema 21.7 Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud

QUÉ HAY QUE SABER

- Prevalencia = casos existentes / población en un momento; incidencia acumulada = casos nuevos / población inicialmente sana en un período; densidad de incidencia = casos nuevos / tiempo-persona.
- Mortalidad infantil = defunciones de menores de 1 año / nacidos vivos × 1.000 (en Chile ~6-7 por mil); neonatal <28 días, postneonatal 28 días a 11 meses. Ejemplo: 16 muertes y 2.000 nacidos vivos = 8 por mil.
- Razón de mortalidad materna = muertes durante el embarazo o hasta 42 días postparto por causas obstétricas / nacidos vivos × 100.000; el denominador son nacidos vivos.
- Letalidad = fallecidos por la enfermedad / casos de la enfermedad (gravedad); mortalidad específica = fallecidos por la causa / población total.
- Chile: la mayor parte de la mortalidad infantil es neonatal (prematurez, malformaciones, afecciones perinatales). Endemia = presencia habitual y estable; epidemia = exceso sobre lo esperado.

PREGUNTAS (15)

Pregunta de práctica

En una comuna, durante un año, hubo 2.000 nacidos vivos y 16 defunciones de menores de 1 año. De estas, 10 ocurrieron en menores de 28 días. **¿Cuál es la tasa de mortalidad infantil de la comuna?**

A) 0,8 por 1.000 nacidos vivos
B) 5 por 1.000 nacidos vivos
C) 3 por 1.000 nacidos vivos
D) 8 por 100.000 nacidos vivos
E) 8 por 1.000 nacidos vivos

Respuesta E. Tasa de mortalidad infantil = defunciones de menores de 1 año / nacidos vivos del mismo período × 1.000 = 16/2.000 × 1.000 = 8 por mil. La neonatal (menores de 28 días) sería 10/2.000 × 1.000 = 5 por mil, y la postneonatal 6/2.000 × 1.000 = 3 por mil.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 2 · texto original del banco, sin revisar

¿Cuál es el mejor indicador para medir la efectividad de la campaña de vacunación contra la influenza?

A) La tasa de mortalidad por influenza
B) La tasa de letalidad de la influenza
C) La tasa de incidencia de influenza
D) La tasa de prevalencia de influenza
E) La tasa de cobertura de vacunación contra la influenza

Respuesta C. Las vacunas intentan disminuir la incidencia de las patologías infecciosas y esa es la forma en que se mide su efectividad. Sin embargo, hay algunas vacunas que solo logran disminuir los casos graves (ej. rotavirus y recientemente Covid-19 en contra de las variantes del virus).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 20 · texto original del banco, sin revisar

¿A qué indicador corresponde la siguiente ecuación? (Muertes en menores de 28 días / nacidos vivos) x 1.000

A) Tasa de mortalidad infantil
B) Tasa de mortalidad perinatal
C) Tasa de mortalidad neonatal
D) Tasa de mortalidad neonatal precoz
E) Tasa de mortalidad postneonatal

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Tasa de mortalidad perinatal). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Tasa de mortalidad infantil, Tasa de mortalidad neonatal) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la p

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 122 · texto original del banco, sin revisar

¿Cuál de los siguientes indicadores es de elección para evaluar la efectividad de una campaña de vacunación contra la influenza?

A) Mortalidad mensual por influenza
B) Tasa de cobertura de vacunación
C) Incidencia semanal por influenza
D) Prevalencia de influenza
E) Letalidad mensual de la influenza

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Tasa de cobertura de vacunación). La influenza es una de las infecciones respiratorias altas más importantes debido a la intensidad de sus síntomas y su potencial de complicarse con neumonía viral o sobreinfección bacteriana. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 2 · texto original del banco, sin revisar

¿Cuál es el mejor indicador para evaluar la efectividad de una campaña de vacunación contra la influenza?

A) Tasa de mortalidad por influenza
B) Cobertura vacunal alcanzada
C) Tasa de incidencia semanal
D) Número de hospitalizaciones evitadas
E) Porcentaje de población inmunizada

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Tasa de incidencia semanal). Tasa de incidencia semanal. La influenza es una de las infecciones respiratorias altas más importantes debido a la intensidad de sus síntomas y su potencial de complicarse con neumonía viral o sobreinfección bacteriana. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 3 · texto original del banco, sin revisar

El indicador de letalidad de la influenza corresponde a lo siguiente:

A) Casos de influenza / población general
B) Casos de influenza / muertes influenza
C) Casos de influenza / población expuesta
D) Muertes por influenza / Casos de influenza
E) Muertes por influenza / población general

Respuesta D. La letalidad son las muertes/casos, es decir, la probabilidad de morirse si es que se enferma. La incidencia son casos/población. La mortalidad es muertes/población. El ataque es la incidencia durante un brote, tomando en cuenta solo la población expuesta al riesgo: muestra muy claramente la trasmisibilidad. Population (in millions>

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 51 · texto original del banco, sin revisar

Mueren 7 niños menores de 1 año por cada 1000 RNV. Cómo se llama el parámetro: a. Tasa de mortalidad infantil

B) Tasa de mortalidad Neonatal
C) Mortalidad neonatal tardía
D) Mortalidad
E) Letalidad
E) Control sano habitual

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Tasa de mortalidad Neonatal, Mortalidad neonatal tardía) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 3 · texto original del banco, sin revisar

¿A qué corresponde el siguiente indicador: "Muertes antes de los 28 días / Total de nacidos vivos"?

A) Tasa de mortalidad perinatal
B) Tasa de mortalidad neonatal
C) Tasa de mortalidad infantil
D) Tasa de mortalidad posneonatal
E) Índice de mortalidad materna

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Tasa de mortalidad neonatal). Tasa de mortalidad neonatal. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 100 · texto original del banco, sin revisar

¿Cuál es el indicador que más se utiliza para reflejar el nivel de desarrollo de los países?

A) Tasa de morbilidad general
B) Tasa de mortalidad general
C) Tasa de fecundidad
D) Tasa de natalidad
E) Tasa de mortalidad infantil

Respuesta E. La mortalidad infantil refleja muy bien el desarrollo de los países, junto a la expectativa de vida.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 137 · texto original del banco, sin revisar

¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al indicador de letalidad por influenza?

A) Número de casos de influenza / Número de fallecidos por influenza
B) Número de fallecidos por influenza / Población general
C) Número de casos de influenza / Población general
D) Número de fallecidos por influenza / Número de casos de influenza
E) Número de casos de influenza / Población expuesta

Respuesta D. Letalidad: La letalidad se define como la probabilidad de morir si se contrae una enfermedad. Se calcula dividiendo el número de muertes causadas por la enfermedad entre el total de casos de esa enfermedad.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 119 · texto original del banco, sin revisar

Durante el año 2012 en Chile se presentaron 60 casos de meningitis causadas por la Neisseria Meningitidis serotipo W135, de los cuales 20 fallecieron por causa atribuible a esta enfermedad. Por lo tanto la letalidad de la N.Meningitidis serotipo W135 durante el 2013 fue:

A) 25%
B) 66%
C) 50%
D) 33%
E) 75%

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (33%). 20/60 = 0,33 = 33%. Esta clase revisa el diagnóstico y manejo de la meningitis bacteriana, viral y tuberculosa. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 14 · texto original del banco, sin revisar

Tras analizar una tabla que compara la tasa de mortalidad y la tasa de mortalidad proporcional para distintas patologías entre un periodo inicial y uno tardío: ¿Qué conclusión es posible obtener?

A) La variación en la mortalidad proporcional se explica por las variaciones en la tasa de mortalidad de dicha enfermedad
B) La tasa de mortalidad por cáncer y por otras causas se mantuvo constante en el 2empo
C) El aumento en la tasa de mortalidad por patología cardiovascular se debe al envejecimiento de la población
D) La disminución de la proporción de pacientes que mueren por cáncer y otras causas se explica por la disminución de la mortalidad por dichas causas
E) La tasa de mortalidad general se man2ene estable

Respuesta B. Aunque al inicio parece difícil, es una pregunta bastante sencilla. La mortalidad por patología cardiovascular sube de 60/1000 a 150/1000. En cambio la mortalidad por cáncer y por otras causas se mantienen constantes en 30/1000 cada una (por eso es correcta la B y falsa la D). Con esto, aumenta la mortalidad general de 120/1000 a 210/1000 (por tanto, es falsa la E) y cambian las mortalidades propo

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 67 · texto original del banco, sin revisar

La tasa de natalidad de un país se calcula como el número de nacidos vivos en un año dividido por la población total a mediados de año, multiplicado por 1.000. ¿Cuál es el denominador correcto de este indicador?

A) Población total a mediados del año
B) Número de mujeres en edad fértil
C) Número de embarazos totales
D) Población mayor de 15 años
E) Total de defunciones del año

Respuesta A. Tasa bruta de natalidad = (nacidos vivos en el año / población total a mitad del año) × 1.000. El denominador es la población total (no solo mujeres fértiles, que corresponde a la tasa de fecundidad).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 67 · texto original del banco, sin revisar

¿Cuál de los siguientes parámetros es más adecuado para determinar la gravedad de una enfermedad?

A) Años de vida saludable perdidos
B) Tasa de mortalidad
C) Tasa de letalidad
D) Tasa de incidencia
E) Tasa de ataque

Respuesta A. , C?. La letalidad es un indicador clásico de gravedad, pero los años de vida saludables perdidos también lo son, e incluso es mejor, cuando se trata de enfermedades graves, pero que no causan la muerte, sino que dejan secuelas y causan invalidez. Yo marqué C.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 80 · texto original del banco, sin revisar

¿A qué indicador corresponde la siguiente afirmación "De 100 pacientes tuberculosos, 13 fallecen"?

A) Valor absoluto
B) Razón
C) Frecuencia relativa
D) Índice
E) Tasa

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Tasa). Es la tasa de letalidad (probabilidad de fallecer si se enferma).. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

7.01.3.010 Etapas del diagnóstico de situación de salud

Dónde se enseña: Tema 21.5 Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

QUÉ HAY QUE SABER

- Secuencia del diagnóstico de situación de salud participativo: reunir datos objetivos y percepción comunitaria, describir el perfil de salud, priorizar los problemas y definir estrategias de intervención con la comunidad.
- Fase de recolección: censos, estadísticas vitales, REM del CESFAM, registros clínicos y talleres participativos.
- Priorización con criterios de magnitud, trascendencia, vulnerabilidad (existencia de intervención eficaz) y factibilidad; también método de Hanlon.
- Última fase: plan de acción intersectorial y monitoreo; los datos y la prevalencia son etapas iniciales, no el cierre.
- No se prioriza antes de escuchar a la comunidad ni solo por la prevalencia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 136

Un CESFAM realiza un diagnóstico de salud participativo de su comunidad, en conjunto con la junta de vecinos y el consejo de desarrollo local. **¿Cuál es la última fase del diagnóstico de salud participativo?**

A) La comprobación de los problemas de salud referidos por la comunidad
B) La determinación de estadísticas y datos objetivos y completos
C) La determinación de la prevalencia de las patologías más importantes de la comunidad
D) La definición de estrategias de intervención priorizadas
E) La realización de estudios experimentales

Respuesta D. El diagnóstico participativo parte reuniendo datos objetivos y la percepción de la comunidad, luego prioriza los problemas, y termina definiendo estrategias de intervención priorizadas en conjunto con la comunidad. Los datos y la prevalencia son etapas iniciales, no el cierre.

7.01.3.011 Fuentes de información para el diagnóstico

Dónde se enseña: Tema 21.13 Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

QUÉ HAY QUE SABER

- Fuentes de información en salud: estadísticas vitales (certificado de defunción y nacimiento, Registro Civil, DEIS-MINSAL, INE), notificación de enfermedades, REM, ficha clínica, egresos hospitalarios.
- Encuestas: Encuesta Nacional de Salud (prevalencias y factores de riesgo), CASEN (datos socioeconómicos) y Censo (datos poblacionales).
- La fuente primaria de las estadísticas de mortalidad es el certificado médico de defunción, por lo que el correcto llenado por el médico es clave.
- Fuentes primarias (recolectadas para el estudio) vs secundarias (registros existentes); considerar calidad, cobertura y subregistro.
- El médico general genera información con cada ficha, certificado y notificación: de su calidad depende el diagnóstico de salud.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un equipo de salud pública quiere conocer las principales causas de muerte de la región en los últimos 5 años para su diagnóstico de situación de salud. **¿Cuál es la fuente primaria de las estadísticas oficiales de mortalidad en Chile?**

A) El certificado médico de defunción
B) La Encuesta Nacional de Salud
C) El Censo de población
D) Las fichas clínicas hospitalarias
E) La encuesta CASEN

Respuesta A. Las estadísticas de mortalidad se construyen a partir del certificado médico de defunción, inscrito en el Registro Civil y procesado por el DEIS del Ministerio de Salud y el INE. La Encuesta Nacional de Salud entrega prevalencias de enfermedades y factores de riesgo; el Censo, datos poblacionales; y la CASEN, datos socioeconómicos.

7.01.3.012 Ejecución de un diagnóstico

Dónde se enseña: Tema 21.5 Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

QUÉ HAY QUE SABER

- Ejecución de un diagnóstico de salud en el CESFAM: delimitar el territorio y población a cargo, recolectar datos, describir según persona, lugar y tiempo, y analizar determinantes.
- Característica esencial: debe ser participativo, incorporando a la comunidad (junta de vecinos, consejo de desarrollo local) además de los datos cuantitativos.
- Luego se priorizan problemas (magnitud, trascendencia, vulnerabilidad, factibilidad) y se programan acciones con responsables, metas e indicadores.
- Se actualiza periódicamente y alimenta el plan de salud comunal.
- Herramienta epidemiológica adecuada para identificar qué grupos, sectores y épocas concentran un problema: epidemiología descriptiva.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

El equipo de un CESFAM debe realizar el diagnóstico de situación de salud de su población a cargo, conforme al Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria. **¿Qué característica es esencial en la ejecución de este diagnóstico?**

A) Limitarse a las enfermedades de notificación obligatoria
B) Basarse exclusivamente en los egresos hospitalarios
C) Ser elaborado únicamente por la dirección del establecimiento
D) Incorporar la participación de la comunidad e integrar información cuantitativa y cualitativa
E) Realizarse una sola vez, al inaugurar el centro

Respuesta D. El diagnóstico de situación de salud debe ser participativo: combina datos cuantitativos (demográficos, morbimortalidad, factores de riesgo, recursos) con la percepción de la comunidad sobre sus problemas. Culmina en la priorización de problemas y la programación de acciones, y se actualiza periódicamente.

7.01.3.013 Concepto y campo de la epidemiología

Dónde se enseña: Tema 21.6 Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

QUÉ HAY QUE SABER

- Epidemiología: estudio de la frecuencia, distribución y determinantes de los estados o eventos de salud en poblaciones, y aplicación de ese conocimiento al control de los problemas.
- Descriptiva: caracteriza según persona, lugar y tiempo y genera hipótesis; analítica: contrasta hipótesis y establece asociación y causalidad (cohortes, casos y controles, experimentos).
- Campo amplio: infecciones, enfermedades crónicas, lesiones, factores de riesgo, evaluación de servicios y programas; no se limita a las enfermedades transmisibles.
- La bioestadística es una herramienta de la epidemiología, no la rama que contrasta hipótesis.
- Clave de examen: la rama que obtiene información mediante el contraste de hipótesis es la epidemiología analítica.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

En la primera clase de epidemiología se pide a los alumnos elegir la definición más completa de la disciplina. **¿Cuál es la mejor definición de epidemiología?**

A) Estudio exclusivo de las epidemias de enfermedades infecciosas
B) Estudio de la distribución y de los determinantes de los estados de salud en poblaciones, y su aplicación al control de los problemas de salud
C) Ciencia que trata a los pacientes individuales según la evidencia
D) Rama de la estadística que estudia los ensayos clínicos
E) Disciplina que administra los recursos de los servicios de salud

Respuesta B. La epidemiología estudia la frecuencia y distribución (epidemiología descriptiva) y los determinantes (epidemiología analítica) de los eventos de salud en poblaciones, y aplica ese conocimiento al control de los problemas. No se limita a las infecciones: incluye enfermedades crónicas, lesiones, factores de riesgo y evaluación de servicios.

7.01.3.014 Epidemiología descriptiva

Dónde se enseña: Tema 21.7 Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud

QUÉ HAY QUE SABER

- Epidemiología descriptiva: responde quién (persona: edad, sexo, ocupación), dónde (lugar) y cuándo (tiempo: tendencias, estacionalidad, conglomerados).
- Cuantifica la magnitud del problema, identifica grupos de riesgo y genera hipótesis; precede a la etapa analítica.
- Medidas: prevalencia, incidencia, mortalidad, letalidad; el estudio de prevalencia (transversal) mide exposición y enfermedad en un mismo momento.
- Términos: endemia (presencia habitual y estable con variaciones estacionales), epidemia (exceso sobre lo esperado), pandemia (extensión mundial), brote (casos relacionados en tiempo corto).
- Las medidas de asociación corresponden a la epidemiología analítica, no a la descriptiva.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 152

¿Cuál de las siguientes patologías no es autóctona de Chile? **Elige la alternativa correcta.**

A) Síndrome pulmonar por hantavirus
B) Leptospirosis
C) Influenza
D) Dengue
E) Malaria

Respuesta E. En Chile no hay malaria autóctona: todos los casos son importados. El dengue sí tiene transmisión local en Isla de Pascua, donde existe el vector.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 98

En una región del país, una enfermedad infecciosa presenta año tras año un número de casos similar, con aumentos esperables en invierno. **¿Qué significa que una enfermedad sea endémica?**

A) Que mantiene una frecuencia relativamente estable en la zona, con sus variaciones estacionales
B) Que presenta muchos más casos que los habituales para la zona geográfica
C) Que se extiende a todos los lugares del planeta
D) Que presenta varios casos, relacionados entre sí, en un corto período de tiempo
E) Que presenta casos escasos, sin poder identificar un patrón

Respuesta A. Endemia es la presencia habitual de una enfermedad en una zona, con frecuencia relativamente estable y sus variaciones estacionales. Epidemia es un exceso de casos sobre lo esperado, pandemia es una epidemia de extensión mundial y brote son casos relacionados en un tiempo corto.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 129 · texto original del banco, sin revisar

Si se quiere hacer un estudio donde se describe en un grupo de niños cuales son los FR, edad, enfermedades?, cómo se llamaría:

A) Analitico
B) Ecológico
C) Descriptivo
D) Control sano habitual
E) Derivar a especialista

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Descriptivo). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Analitico, Ecológico) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 47 · texto original del banco, sin revisar

Si se mejorara el tratamiento de una enfermedad crónica, y se mantiene la incidencia, ¿qué pasará con la prevalencia?

A) Aumenta
B) No se modifica
C) Disminuye
D) No se puede determinar
E) Depende de la enfermedad

Respuesta A. Si la enfermedad crónica es incurable, al mejorar el tratamiento, se muere menos gente y aumenta la prevalencia. Si fuera curable, sí disminuiría la prevalencia, ya que se curarían. Sin embargo, la D y la E hacen pensar que la respuesta que se quería como correcta era la A.

7.01.3.015 Usos de la epidemiología en el control de enfermedades

Dónde se enseña: Tema 21.4 Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile

QUÉ HAY QUE SABER

- Usos de la epidemiología en el control de enfermedades: vigilancia, investigación de brotes, identificación de factores de riesgo y evaluación de intervenciones (vacunas, programas).
- Control de infecciosas: vacunación masiva es la estrategia de mayor impacto sobre la mortalidad por infecciones respiratorias (protege al vacunado y genera inmunidad de rebaño); cuarentena y aislamiento son complementarias y transitorias.
- Éxito de una campaña de vacunación (efectividad): disminución de la incidencia de la enfermedad; la cobertura es solo un indicador de proceso.
- La profilaxis antibiótica no sirve contra virus.
- Ejemplo: Programa Nacional de Inmunizaciones, con cobertura alta sostenida para mantener inmunidad de rebaño.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 69

Se desea evaluar los resultados de una campaña de vacunación en la población. **¿Cuál es el mejor indicador para determinar el éxito de una campaña de vacunación?**

A) Tasa de incidencia
B) Tasa de prevalencia
C) Tasa de hospitalizaciones
D) Tasa de mortalidad
E) Tasa de cobertura de vacunación

Respuesta A. El objetivo de una vacuna es prevenir casos nuevos, por lo que su éxito (efectividad) se mide por la disminución de la incidencia de la enfermedad. La cobertura es un indicador de proceso: dice cuántos se vacunaron, no si se evitó la enfermedad. La mortalidad depende además de la letalidad y del tratamiento.

7.01.3.016 Vigilancia epidemiológica y estudio de brotes

Dónde se enseña: Tema 21.4 Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile

QUÉ HAY QUE SABER

- Vigilancia epidemiológica: recolección, análisis e interpretación sistemática de datos para actuar; activa (notificación obligatoria caso a caso), centinela (muestreo en centros seleccionados) y pasiva (estadísticas generales).
- Vigilancia centinela: enfermedades frecuentes y poco graves (infecciones respiratorias altas, diarreas, influenza, varicela); no es notificación caso a caso.
- Notificación obligatoria (DS N°7) en Epivigila: inmediata ante sospecha, sin esperar laboratorio (meningococo, hantavirus, sarampión, rubéola, rabia, cólera, botulismo, brotes de ETA); diaria dentro de 24 h (TBC, sífilis, gonorrea, VIH, hepatitis virales, coqueluche, Chagas, tétanos).
- Estudio de brote: confirmar el diagnóstico y la existencia del brote, definir caso, buscar casos, describir por persona-lugar-tiempo, plantear hipótesis (casos y controles), aplicar control y comunicar.
- Brote de ETA: ≥2 personas con el mismo cuadro tras un alimento común; notificar a la SEREMI, inspección sanitaria, decomiso, coprocultivos, tasa de ataque y riesgo relativo por alimento.

PREGUNTAS (10)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 44

¿Por qué la meningococcemia es una enfermedad de notificación inmediata? **Seleccione la alternativa correcta:**

A) Para aislar a los contactos
B) Para vacunar a la familia
C) Para identificar y manejar a los contactos
D) Para detectar casos secundarios
E) Por la gravedad de la enfermedad

Respuesta C. La notificación inmediata permite identificar a los contactos y darles quimioprofilaxis (rifampicina, ciprofloxacino o ceftriaxona en la embarazada) a tiempo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 107

Respecto al DIEP (Departamento de Infecciones y Epidemiología del Paciente) en hospitales chilenos, ¿cuál es su función principal? **Seleccione la alternativa correcta:**

A) Vigilar, prevenir y controlar las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS)
B) Gestionar los recursos humanos del hospital
C) Supervisar la farmacia hospitalaria
D) Coordinar las licencias médicas
E) Auditar los estados financieros del hospital

Respuesta A. El DIEP (o comité de IAAS) de los hospitales chilenos tiene como función primordial la vigilancia epidemiológica, la prevención y el control de las infecciones asociadas a la atención de salud.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 60

Usted atiende a 5 pacientes que consultan por vómitos y diarrea de inicio agudo en el mismo servicio de urgencia. Todos ellos son compañeros de trabajo, que almuerzan en el mismo comedor, por lo que se sospecha una intoxicación alimentaria. Además del manejo específico de los síntomas y patología de cada uno de ellos, la medida más adecuada es:
Seleccione la alternativa correcta:

A) Notificar al encargado de epidemiología del Hospital
B) Realizar un interrogatorio detallado a cada uno de los pacientes, para identificar el agente causal
C) Notificar a la Seremi de Salud
D) Notificar al Director del Hospital
E) Notificar a la Superintendencia de Salud

Respuesta C. La sospecha de un brote de intoxicación alimentaria es de notificación obligatoria, y en Chile la notificación se hace a la Seremi de Salud ante la sola sospecha, para que la autoridad sanitaria tome medidas y contenga el brote.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 98

¿Mediante qué estrategia epidemiológica se debe enfrentar la sospecha de un brote de intoxicación alimentaria para su adecuada identificación y control? **Seleccione la alternativa correcta:**

A) Vigilancia activa
B) Estudio experimental
C) Vigilancia centinela
D) Estudio analítico
E) Vigilancia pasiva

Respuesta A. Las intoxicaciones alimentarias se manejan con vigilancia activa, es decir, con notificación obligatoria ante la sola sospecha. La vigilancia centinela se usa en infecciones frecuentes y poco graves (solo informan algunos centros), y la pasiva en infecciones leves o poco transmisibles.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 44

¿Qué tipo de vigilancia se utiliza en patologías como las infecciones respiratorias altas, las diarreas y las enfermedades de transmisión sexual? **¿Cuál es el tipo de vigilancia correcto?**

A) Vigilancia activa
B) Vigilancia centinela
C) Vigilancia de notificación obligatoria
D) Estudios de prevalencia
E) Estudios experimentales

Respuesta B. La vigilancia centinela se usa en enfermedades frecuentes y de menor gravedad, como infecciones respiratorias altas, diarreas y varicela, con muestreo en centros de salud determinados; excepto sífilis y gonorrea, que sí son de notificación obligatoria.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 106 · texto original del banco, sin revisar

El médico de un CESFAM detecta un brote de hepatitis A en su sector. ¿A qué autoridad sanitaria debe notificar de forma inmediata?

A) SEREMI de Salud
B) Ministerio de Salud directamente
C) FONASA
D) ISP
E) Municipalidad

Respuesta A. En Chile, las enfermedades de notificación obligatoria inmediata (ENNOI) como brotes de hepatitis A se notifican al SEREMI de Salud de la región correspondiente dentro de las 24 horas.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 142 · texto original del banco, sin revisar

En la vigilancia de las enfermedades transmisibles, ¿cuál es el parámetro que se utiliza para definir si la notificación de los casos de dicha enfermedad es de tipo diaria o inmediata?

A) Periodo de incubación
B) Oportunidad de control y prevención
C) Letalidad y prevalencia
D) Número de casos
E) Disponibilidad de vacuna

Respuesta C. La velocidad con la que se notifica considera la gravedad de la enfermedad (letalidad) y la frecuencia de casos (más que prevalencia es la incidencia, pero es la única respuesta aceptable). En general solo se notifican enfermedades graves y que son infrecuentes y mientras más graves, se notifican más rápido.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 24 · texto original del banco, sin revisar

¿Cuál es la mejor estrategia de vigilancia para una enfermedad infectocontagiosa, que se transmite a través de la contaminación de acuíferos?

A) Vigilancia activa
B) Vigilancia pasiva
C) Vigilancia estacional
D) Encuestas
E) Centros centinelas

Respuesta A. Pregunta muy rara. La vigilancia activa de los acuíferos (aguas superficiales y aguas subterráneas) es lo más razonable, con toma de muestras y análisis periódicos de las aguas en cuestión, más análisis directo, en caso de reportarse casos sospechosos (por eso marcamos la vigilancia activa como respuesta). Pero la verdad es que, en Chile, las diarreas (incluyendo el cólera, por ejemplo), se vigila

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 41 · texto original del banco, sin revisar

La notificación obligatoria de ciertas enfermedades transmisibles tiene como objetivo:

A) Evaluar la efectividad de las vacunas administradas a la población
B) Identificar las enfermedades infecciosas más importantes en la población
C) Determinar la propagación de las enfermedades más letales
D) Identificar y controlar situaciones epidémicas
E) Reunir información estadística completa y confiable, para determinar las políticas de salud

Respuesta D. La vigilancia activa (notificación obligatoria) busca identificar los brotes de manera rápida, para poder contenerlo, haciendo un adecuado manejo de los casos (aislamiento y tratamineto) y de los contactos (profilaxis y observación).

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 5 · texto original del banco, sin revisar

La notificación obligatoria de algunas enfermedades transmisibles tiene como objetivo:

A) Evaluar la efectividad de las vacunas administradas a la población
B) Identificar las principales enfermedades transmisibles en la población
C) Determinar la propagación de las enfermedades infecciosas más importantes
D) Ayudar a identificar y controlar situaciones epidémicas
E) Reunir información estadística completa y confiable, para determinar las políticas de salud

Respuesta D. La notificación obligatoria es una medida de vigilancia activa, que busca conocer rápidamente sobre la presencia de casos de una enfermedad infecciosa, de modo de identificar y manejar a los contactos, tanto en brotes como en epidemias (y pandemias). La efectividad de vacunas se mide con ensayos clínicos o de campo. Las demás opciones se pueden lograr con un buen registro epidemiológico, sin neces

7.01.3.017 Usos de la epidemiología en el diagnóstico de situación de salud

Dónde se enseña: Tema 21.5 Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

QUÉ HAY QUE SABER

- La epidemiología describe la magnitud y distribución de los problemas de salud según persona, lugar y tiempo, e identifica los grupos de riesgo para priorizar y focalizar recursos en el diagnóstico de situación.
- Ejemplo: para saber qué edades, sectores y épocas concentran la obesidad infantil se usa la epidemiología descriptiva; los diseños analíticos buscan causas.
- Insumos: estadísticas vitales, morbilidad, Encuesta Nacional de Salud, REM y factores de riesgo.
- Indicadores: incidencia, prevalencia, mortalidad específica, años de vida potencialmente perdidos.
- Resultado: priorización con magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un equipo comunal, en su diagnóstico de situación de salud, quiere identificar qué grupos de edad, sectores de la comuna y períodos del año concentran la mayor obesidad infantil, para orientar sus recursos. **¿Qué herramienta epidemiológica es la más adecuada para este fin?**

A) Análisis de costo-efectividad
B) Ensayo clínico aleatorizado
C) Epidemiología descriptiva, según persona, lugar y tiempo
D) Auditoría clínica
E) Estudio de cohortes a 20 años

Respuesta C. En el diagnóstico de situación, la epidemiología describe la magnitud y distribución de los problemas de salud según persona, lugar y tiempo, identificando grupos de riesgo para priorizar y focalizar intervenciones. Los diseños analíticos o experimentales buscan causas o evalúan intervenciones, lo que no es el objetivo aquí.

7.01.3.018 Epidemiología analítica

Dónde se enseña: Tema 21.6 Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

QUÉ HAY QUE SABER

- Epidemiología analítica: contrasta hipótesis comparando grupos para establecer asociación y causalidad, con estudios de cohorte, casos y controles y experimentales.
- Pregunta clave del diseño: ¿el investigador asignó la exposición? Sí = experimental; no = observacional. Luego, ¿cómo se seleccionó a los sujetos? Por exposición = cohortes; por enfermedad = casos y controles.
- Medidas: riesgo relativo en cohortes y ensayos; odds ratio en casos y controles.
- Ambigüedad temporal en estudios transversales: no establecen causalidad.
- Se complementa con la evaluación de sesgos, confusión y criterios de causalidad de Bradford Hill.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 99

La salud pública dispone de distintas ramas para obtener y analizar información sobre los problemas de salud. **¿Qué rama de la Salud Pública se preocupa de obtener información a través del contraste de hipótesis?**

A) Epidemiología descriptiva
B) Bioestadística
C) Prevención de salud
D) Epidemiología analítica
E) Vigilancia epidemiológica

Respuesta D. La epidemiología descriptiva caracteriza los problemas según persona, lugar y tiempo y genera hipótesis; la epidemiología analítica las pone a prueba, comparando grupos para establecer asociación y causalidad, mediante estudios de cohorte, casos y controles y experimentales. La bioestadística es una herramienta, no la rama que plantea el contraste.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 21 · texto original del banco, sin revisar

Se realiza un estudio que muestra que en la comuna A, el consumo de drogas es de un 40%, mientras que en la comuna B, es de 10%. El diseño de estudio más adecuado, para determinar las causas de estas diferencias, es:

A) Ecológico
B) Descriptivo
C) Analítico
D) De prevalencia
E) De incidencia Respuesta: Las relaciones de causalidad, se estudian con la epidemiología analític

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Analítico). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Ecológico, Descriptivo) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

7.01.3.019 Medidas de asociación e impacto

Dónde se enseña: Tema 21.7 Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud

QUÉ HAY QUE SABER

- Tabla 2x2: a expuestos enfermos, b expuestos sanos, c no expuestos enfermos, d no expuestos sanos. Riesgo relativo = [a/(a+b)] / [c/(c+d)] en cohortes y ensayos; odds ratio = (a×d)/(b×c) en casos y controles.
- RR u OR = 1 sin asociación; >1 factor de riesgo; <1 factor protector. Es significativo solo si el IC 95% no incluye 1 (para reducción absoluta de riesgo, el valor nulo es 0).
- Impacto: reducción absoluta del riesgo = riesgo control – riesgo tratamiento; reducción relativa = RAR / riesgo control; NNT = 1/RAR, redondeado hacia arriba (12% vs 8% = RAR 4% = NNT 25).
- Riesgo atribuible y riesgo atribuible porcentual son medidas de impacto, no de cuántas veces más riesgo.
- Trampa: un OR de 1,3 con IC 0,86-2,1 cruza el 1, la asociación no es significativa; un OR no es 'un 30% más de riesgo' real.

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 71

Se busca la asociación entre distintos parámetros con el cáncer de tiroides, en un estudio de caso control, con el Odds Ratio (OR) más un intervalo de confianza (IC) al 95%: antecedentes familiares OR 1,88 IC 0,56 a 4,01; edad OR 2,6 IC 0,95 a 3,17; sexo masculino OR 0,56 IC 0,33 a 0,87; exposición a radiación OR 1,52 IC 0,91 a 2,01; tiroiditis de Hashimoto OR 4,6 IC 0,7 a 6,2. **¿Qué factor es más importante en esta asociación?**

A) Antecedentes familiares: OR 1,88; IC 0,56 a 4,01
B) Edad: OR 2,6; IC 0,95 a 3,17
C) Sexo masculino: OR 0,56; IC 0,33 a 0,87
D) Exposición a radiación: OR 1,52; IC 0,91 a 2,01
E) Tiroiditis de Hashimoto: OR 4,6; IC 0,7 a 6,2

Respuesta C. Solo la opción del sexo masculino tiene un intervalo de confianza que no cruza el uno, con ambos límites bajo uno: es la única estadísticamente significativa, y corresponde a un factor protector, ya que su Odds Ratio es menor a uno. Las otras cuatro, aunque tienen Odds Ratio numéricamente más llamativos, tienen intervalos que incluyen el valor nulo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 31

Se busca la medida de asociación más adecuada para establecer cuántas veces aumentan los casos de asma en la población fumadora, en comparación con la población no fumadora. **¿Cuál de las siguientes medidas de asociación es la más adecuada?**

A) Riesgo relativo
B) Riesgo atribuible
C) Razón de prevalencias
D) Tasa de incidencia
E) Riesgo atribuible porcentual

Respuesta A. El Riesgo Relativo es, por definición, la razón entre la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos: expresa directamente cuántas veces más frecuente es el evento en un grupo respecto al otro. El riesgo atribuible y el riesgo atribuible porcentual son medidas de impacto, no de cuántas veces más riesgo hay.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 35

Un estudio de cohortes busca establecer la asociación entre la exposición a estrógenos y el cáncer de ovario. Luego de analizar los datos, se obtiene que el Odds Ratio es 1,3 con un intervalo de confianza al 95% de 0,86 a 2,1. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con estos resultados?**

A) Las mujeres expuestas a estrógeno tienen 1,3 veces más riesgo de presentar cáncer de ovario
B) Las mujeres expuestas a estrógeno tienen 30% más de riesgo de presentar cáncer de ovario
C) Existe una asociación entre el uso de estrógenos y el desarrollo de cáncer de ovario, pero no es significativa
D) Las mujeres que tienen cáncer de ovario estuvieron expuestas a un 30% más de estrógeno
E) Se prueba la asociación entre el uso de estrógenos y el desarrollo de cáncer de ovario, pero no es extrapolable

Respuesta C. El Odds Ratio de 1,3 sugiere un aumento del riesgo, pero su intervalo de confianza al 95% va de 0,86 a 2,1 e incluye el valor nulo de 1,0. Eso significa que la asociación observada no alcanza significancia estadística: no se puede descartar que el resultado se deba al azar, aunque el punto estimado sugiera un factor de riesgo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 103 · texto original del banco, sin revisar

La medida que mejor estima la diferencia de riesgo entre un grupo expuesto y otro no expuestoa un factor de riesgo en una misma población es:

A) Riesgo atribuible
B) Odds Ratio
C) Riesgo Relativo
D) Incidencia acumulada
E) Razón de incidencias

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Riesgo atribuible). Es la definición de RA = Ie - Io. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 29 · texto original del banco, sin revisar

Se realiza un estudio de casos y controles que busca establecer la asociación entre el uso de anticonceptivos orales y cáncer. Luego de analizar los datos se obtiene que el Odds Ratio 1,3 con intervalo de confianza al 95% con valores entre 0,86 y 2,1. Con estos resultados se puede afirmar que:

A) Existe una relación positiva entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de cáncer
B) Existe una relación positiva entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de cáncer, pero que no es estadísticamete significativa
C) Existe una asociación entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de cáncer, pero este resultado no es extrapolable a otras poblaciones
D) Las personas que tienen cáncer consumen un 30% más de anticonceptivos orales
E) Las personas que usan anticonceptivos orales, tienen 1,3 veces más riesgo de desarrollar cáncer.

Respuesta B. El OR pasa por el 1,0 en su intervalo de confianza al 95%, por lo que no es estadísti- camente significativo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 46 · texto original del banco, sin revisar

Un estudio investiga la correlación entre el uso de drogas durante el embarazo y las alteraciones cognitivas en los niños. Para ello, se selecciona a un grupo de niños con discapacidad cognitiva y se compara con otro grupo de niños sanos, realizándole una entrevista a la madre, sobre la exposición a distintos factores de riesgo, durante el embarazo. ¿Qué medida de asociación se debe utilizar en este estudio?

A) Riesgo relativo
B) Riesgo atribuible
C) Riesgo atribuible poblacional
D) Odds ratio
E) Incidencia

Respuesta D. Es un estudio de casos y controles, por lo que se calcula el OR, como medida de asociación. El riesgo relativo también era una medida de asociación (las demás no).

7.01.3.020 Diseños de investigación epidemiológica

Dónde se enseña: Tema 21.6 Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

QUÉ HAY QUE SABER

- Primera pregunta: ¿el investigador asigna la exposición? Sí = experimental (ensayo clínico aleatorizado); no = observacional.
- Observacional con datos agregados de poblaciones (países, comunas) = ecológico; con individuos, ¿selección por exposición (cohortes) o por enfermedad (casos y controles)? Todo medido en un momento = transversal.
- Casos y controles: ideal para enfermedades raras o de larga latencia; mide OR; sesgo de memoria. Cohortes: ideal para exposiciones raras, permite varios desenlaces, mide incidencia y RR; riesgo de pérdidas de seguimiento.
- Ensayo clínico: estándar de oro para eficacia; aleatorización reparte confusores, enmascaramiento (simple, doble, triple ciego) evita sesgos; fases I (20-80 sanos, seguridad), II (100-300 enfermos), III (miles, multicéntrico), IV (poscomercialización).
- Transversal: rápido y barato, estima prevalencia, pero con ambigüedad temporal.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un equipo de salud pública quiere estudiar si la exposición ocupacional al plomo se asocia con el desarrollo de insuficiencia renal crónica. Reclutan a 400 trabajadores de fundiciones, sin enfermedad renal al momento del ingreso, clasificados según su nivel de exposición al plomo en el ambiente laboral, y los siguen anualmente durante 12 años, midiendo la función renal. **¿A qué diseño de estudio corresponde esta investigación?**

A) Estudio de cohortes prospectivo
B) Estudio de casos y controles
C) Estudio transversal
D) Ensayo clínico aleatorizado
E) Estudio ecológico

Respuesta A. Los sujetos se seleccionan sanos al inicio, según su exposición al plomo, y se siguen prospectivamente para registrar la aparición de nuevos casos de insuficiencia renal. Esa estructura, selección por exposición y seguimiento longitudinal, define un estudio de cohortes prospectivo, el diseño de elección para una exposición ocupacional infrecuente.

7.01.3.021 Estudios de prevalencia

Dónde se enseña: Tema 21.6 Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

QUÉ HAY QUE SABER

- Estudio de prevalencia (transversal): mide exposición y enfermedad en un mismo momento, sin seguimiento; entrega prevalencia (ej. Encuesta Nacional de Salud).
- Ventajas: rápido, barato, útil para planificar recursos y servicios.
- Limitación principal: ambigüedad temporal; no puede saber si la causa precedió al efecto, por lo que no establece causalidad ni calcula incidencia.
- Para incidencia o riesgo relativo se necesita seguir a personas inicialmente sanas (cohortes).
- Sensible al sesgo de supervivencia: sobrerrepresenta a enfermos de larga duración.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

La Encuesta Nacional de Salud mide, en un período breve, la presión arterial de una muestra representativa de la población chilena adulta y pregunta si la persona conoce su diagnóstico de hipertensión. **¿Qué medida de frecuencia entrega directamente este tipo de estudio?**

A) Prevalencia
B) Incidencia acumulada
C) Densidad de incidencia
D) Riesgo relativo
E) Letalidad

Respuesta A. Un estudio de prevalencia (transversal) mide exposición y enfermedad en un mismo momento, sin seguimiento, por lo que entrega la proporción de personas que tienen la condición: la prevalencia. Para calcular incidencia o riesgo relativo se requiere seguir en el tiempo a personas inicialmente sanas, como en un estudio de cohortes.

7.01.3.022 Estudios de casos y controles

Dónde se enseña: Tema 21.6 Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

QUÉ HAY QUE SABER

- Casos y controles: se selecciona por la enfermedad (casos) y sanos comparables (controles) y se indaga hacia atrás la exposición; retrospectivo.
- Diseño de elección para enfermedades raras o de larga latencia (p. ej. cáncer): rápido y barato; es el más eficiente ante enfermedades muy infrecuentes.
- Medida de asociación: odds ratio = (a×d)/(b×c); no se calcula incidencia ni RR porque el investigador fija cuántos enfermos y sanos reclutar.
- Sesgos típicos: de memoria (el enfermo recuerda mejor la exposición), del entrevistador y de selección (Berkson si se reclutan solo en hospital).
- Se controla con registros objetivos, ciego del entrevistador y controles de base comunitaria.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 110

Se busca el diseño de estudio más adecuado para estudiar enfermedades muy infrecuentes en la población. **¿Cuál es el diseño de estudio más adecuado para estudiar enfermedades muy infrecuentes?**

A) Cohortes prospectivas
B) Caso control
C) De prevalencia
D) Ensayo clínico
E) Cohortes retrospectiva

Respuesta B. Casos y controles es el diseño más eficiente frente a enfermedades raras, porque permite reclutar directamente a los pocos enfermos existentes; un estudio de cohortes tendría que seguir a una población enorme durante años para observar un número suficiente de casos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 92 · texto original del banco, sin revisar

¿Cuál es el mejor tipo de estudio para enfermedades poco prevalentes?

A) Serie de casos
B) Estudio de cohortes
C) Ensayo clínico
D) Estudio ecológico
E) Estudios de caso-control

Respuesta E. Casos y controels sirven para: poco prevalentes, bajo presupuesto y enfermedades que demoran mucho en aparecer.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 147 · texto original del banco, sin revisar

Se realiza un estudio donde se desea estudiar los factores de riesgos asociado al lupus, por esto se seleccionan dos grupos, uno de ellos con pacientes diagnosticadas de lupus y el otro de características demográficas similares pero sanos. ¿A qué tipo de estudio corresponde el diseño mencionado anteriormente?

A) Cohorte prospectivo
B) Prevalencia
C) Caso control
D) Ensayo clínico controlado
E) Estudio ecológico

Respuesta C. Falta decir qué se hace con esos pacientes. Si se les preguntan sus factores de riesgo (si fuman, toman, etc) sería casos y controles. No puede ser cohortes, porque no se va a a ver a futuro qué FR desarrollan (sería ilógico), porque ya están enfermos o sanos.

7.01.3.023 Estudios de cohortes

Dónde se enseña: Tema 21.6 Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

QUÉ HAY QUE SABER

- Cohortes: se seleccionan sujetos sanos según estén expuestos o no y se siguen en el tiempo para ver quién enferma (prospectivo, o retrospectivo con registros históricos).
- Diseño de elección para exposiciones infrecuentes (p. ej. tóxico laboral); permite evaluar múltiples desenlaces de una misma exposición.
- Mide incidencia y riesgo relativo; la causa precede al efecto, lo que da mayor fuerza causal.
- Desventajas: caro, lento, ineficiente para enfermedades raras; su principal sesgo son las pérdidas de seguimiento.
- Con datos de un solo grupo (65 de 2.000 fumadores con cáncer a 20 años) solo se calcula incidencia acumulada (3,25%); para RR se necesita el grupo no expuesto.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 13

En un estudio de cohortes sobre el tabaco y cáncer de pulmón, luego de 20 años, se determina que 65 de 2.000 pacientes fumadores enfermaron de cáncer. **¿Qué medida es posible calcular con esta información?**

A) Incidencia acumulada en los pacientes fumadores
B) Prevalencia en los pacientes fumadores
C) Riesgo relativo
D) Odds ratio
E) Tasa de ataque en los pacientes fumadores

Respuesta A. Con datos de un solo grupo (los fumadores) solo se puede calcular la incidencia acumulada en ese grupo: 65 dividido en 2.000. Para calcular Riesgo Relativo u Odds Ratio se necesitaría además el dato de los no fumadores, que aquí no está.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 40 · texto original del banco, sin revisar

Se realiza un estudio donde se comparan dos grupos de personas mayores de 60 años, uno de ellos corresponde a hipertensos y el otro de características similares pero sin hipertensos, se siguen por 5 años y se evalúa la aparición de infarto agudo al miocardio o accidente cerebrovascular. Este enunciado corresponde a un estudio de:

A) Corte transversal
B) Caso control
C) Estudio clínico randomizado
D) Cohorte
E) Ensayo de campo

Respuesta D. Diagnóstico: Cohorte (opción D). Se siguen al futuro dos grupos: expuestos y no expuestos a un FR (HTA en este caso). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 49 · texto original del banco, sin revisar

Se hace estudio de FRCV y alimentación en estudiantes medicina en el año 2000. En el 2022 se reevalúa a los mismos para ver aparición de enfermedades cv. Qué tipo de estudio es: a. Cohortes prospectivo.

B) Cohorte retrospectivo
C) Caso control
D) Transversal
D) Hemograma y VHS
E) Ecografía

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Cohorte retrospectivo, Caso control) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

7.01.3.024 Estudios experimentales y cuasiexperimentales

Dónde se enseña: Tema 21.6 Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

QUÉ HAY QUE SABER

- Experimental: el investigador asigna la intervención, que es lo que lo diferencia de los demás diseños; la aleatorización y el ciego son deseables pero no definitorios.
- Ensayo clínico aleatorizado: estándar de oro para causalidad terapéutica; la aleatorización reparte equilibradamente confusores conocidos y desconocidos; el enmascaramiento (simple, doble, triple ciego) evita sesgos de información.
- Fases: I (20-80 voluntarios sanos: seguridad y dosis), II (100-300 pacientes: eficacia preliminar), III (miles, multicéntrico: decide la aprobación), IV (poscomercialización: efectos adversos raros).
- Cuasiexperimental: hay intervención pero sin aleatorización o sin grupo control equivalente.
- Limitación: puede perder validez externa si los criterios de inclusión son muy estrictos; problemas éticos y costo.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 146

Un grupo de investigadores discute qué diseño usar para su próximo estudio y revisa en qué se diferencian los estudios experimentales de los observacionales. **¿Cuál es la característica de los estudios experimentales que los diferencia de los demás tipos de estudios?**

A) La selección es aleatorizada
B) Siempre utilizan triple ciego
C) El investigador controla algunas variables
D) El investigador selecciona los grupos de intervención
E) Utilizan test de hipótesis

Respuesta C. Lo que define a un estudio experimental es que el investigador asigna la intervención, es decir, controla la variable de exposición. La aleatorización y el enmascaramiento son deseables para reducir sesgos, pero no son obligatorios, y los test de hipótesis se usan también en estudios observacionales analíticos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 5 · texto original del banco, sin revisar

Se desea evaluar la efectividad de un nuevo antihipertensivo de la familia de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, para esto, ¿Qué tipo de estudio escogería?

A) Caso control
B) Meta-análisis
C) Cohorte
D) Corte transversal
E) Estudio clínico randomizado

Respuesta E. Por ser un fármaco nuevo es imposible tener estudios para hacer un meta-análisis. Así que lo mejor es el ensayo clínico. Eso sí, lo que se mide es eficacia y no efectividad, pero de todos modos es la respuesta más correcta.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 124 · texto original del banco, sin revisar

Un estudio determina que se deben tratar a 20 pacientes con una intervención, para evitar que uno fallezca. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

A) De incidencia
B) Casos y controles
C) Cohortes anidada
D) Ensayo clínico
E) De prevalencia

Respuesta D. Se calculó el NNT, que en este caso es de 20. Sin embargo, lo preguntado es qué tipo de estudio es y por tratarse de una "intervención", se asume que es un estudio experimental, es decir, un ensayo clínico.

7.01.3.025 Concepto de estudios ecológicos

Dónde se enseña: Tema 21.6 Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

QUÉ HAY QUE SABER

- Estudio ecológico: la unidad de análisis son poblaciones (países, comunas), no individuos; correlaciona promedios de exposición con tasas de enfermedad.
- Ejemplo: tasa de infarto por país según consumo de grasas saturadas, sin seguir a ningún individuo.
- Es observacional, pero ecológico es la clasificación más específica.
- Limitación central: falacia ecológica, asumir que la asociación a nivel de grupo se cumple en cada persona.
- Útil para generar hipótesis con datos ya disponibles, de bajo costo.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 65

En un estudio se analiza la tasa de infarto al miocardio en distintos países según el consumo de grasas saturadas, sin seguir a individuos en el tiempo. **¿Qué tipo de diseño epidemiológico corresponde?**

A) Estudio ecológico
B) Estudio de cohorte
C) Estudio de casos y controles
D) Ensayo clínico aleatorizado
E) Estudio transversal

Respuesta A. La unidad de análisis son países, no individuos: se comparan tasas agregadas de enfermedad entre grupos, sin seguir a ninguna persona. Eso define al estudio ecológico, cuya limitación principal es la falacia ecológica: no se puede inferir la asociación a nivel individual.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 8

En un estudio se miden los niveles plasmáticos de pesticidas en personas de distintos países, obteniéndose los niveles promedio para la población de cada país. Luego, se correlacionan con las tasas de mortalidad por cáncer de cada país. **¿A qué tipo de estudio corresponde?**

A) Observacional
B) Cohortes
C) Experimental
D) Ecológico
E) De contraste de hipótesis

Respuesta D. En el estudio ecológico la unidad de análisis es un grupo (país, región), no el individuo: se correlacionan promedios de exposición con tasas de enfermedad. Es observacional, pero ecológico es la clasificación más específica. Su principal limitación es la falacia ecológica: la asociación entre grupos puede no cumplirse a nivel individual.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 45 · texto original del banco, sin revisar

En un estudio se realiza la medición de los niveles plasmáticos promedio de pesticidas, en la población de distintos países y se correlaciona con las tasas de mortalidad por cáncer. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

A) Ecológico
B) Cohortes
C) Caso control
D) Observacional
E) Experimental

Respuesta A. Es un estudio ecológico clásico, sin embargo, vale la pena mencionar que también es un estudio de tipo observacional (ya que no es experimental).

7.01.3.026 Causalidad y sesgos

Dónde se enseña: Tema 21.9 Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Primero descartar azar, luego sesgo y confusión, y recién entonces evaluar causalidad.
- Error aleatorio (precisión): se reduce aumentando la muestra y se cuantifica con valor p e IC 95%. Sesgo (error sistemático, validez interna): no se corrige aumentando la muestra.
- Sesgos de selección: Berkson (casos y controles solo del hospital), trabajador sano, voluntario. De información: memoria (casos y controles), entrevistador, vigilancia o detección (a un grupo se le busca más, p. ej. anticonceptivos y control de presión más frecuente).
- Confusión: tercera variable asociada a la exposición y causa independiente de la enfermedad, sin ser paso intermedio (tabaco en café y cáncer de páncreas); se controla con estratificación, pareamiento o análisis multivariado.
- Bradford Hill: el único criterio indispensable es la temporalidad (la causa precede al efecto); suman fuerza, dosis-respuesta, plausibilidad, consistencia y cesación de la exposición.

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 68

Según los criterios de causalidad de Bradford Hill, se pregunta cuál es el requisito indispensable para establecer una asociación causal. **¿Cuál es requisito para establecer una asociación causal?**

A) Fuerza de asociación
B) Plausibilidad biológica
C) Respuesta dosis dependiente
D) Secuencia temporal
E) Asociación estadística

Respuesta D. La secuencia temporal es el único criterio de Bradford Hill absolutamente indispensable: si la causa no antecede al efecto, no puede ser la causa. Los demás criterios refuerzan la sospecha de causalidad, pero ninguno es obligatorio por sí solo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 32

Un estudio busca la asociación entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de hipertensión arterial, y concluye que hay mayor hipertensión en las pacientes que usaban anticonceptivos. Sin embargo, las pacientes que recibían anticonceptivos orales fueron controladas tres veces más seguido que las que no los recibían. **¿Qué sesgo se encuentra presente en el estudio descrito?**

A) Sesgo de selección
B) Sesgo de notificación
C) Sesgo de exclusión
D) Sesgo de vigilancia
E) Sesgo del evaluador

Respuesta D. Es un sesgo de vigilancia o detección: al grupo que usaba anticonceptivos se le controló la presión arterial tres veces más seguido, así que era estadísticamente más probable detectar hipertensión en ese grupo solo por haberlo buscado más, no porque el fármaco necesariamente la produjera en esa magnitud.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 170 · texto original del banco, sin revisar

Un problema de los estudios de casos y controles es que, al ser retrospectivo, las personas evaluadas olvidan las situaciones a las que estuvieron expuestos. Aquello produce un tipo de error sistemático, que corresponde a un:

A) Error de clasificación diferencial
B) Sesgo de selección
C) Sesgo de confusión
D) Sesgo de información
E) Error de clasificación no diferencial

Respuesta D. El sesgo de memoria es un tipo de sesgo de información o medida, que afecta al evaluado. Los errores de clasificación son aquellos…

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 75 · texto original del banco, sin revisar

El uso del enmascaramiento (doble ciego controlado) como medida en estudios epidemiológicos tiene como objetivo:

A) Disminuir el sesgo de información
B) Disminuir sesgo de selección (es de información, en específico los subtipos del evaluador y el evaluado, sesgo de selección sería realizar un estudio excluyendo de la muestra de estudio una población especifica y relevante)
C) Darle mayor valor al estudio
D) Disminuir el error aleatorio
E) Hemograma y VHS

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Disminuir el sesgo de información). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Disminuir sesgo de selección (es de informaci, Darle mayor valor al estudio) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales qu

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 94 · texto original del banco, sin revisar

En un estudio se realiza la validación y estandarización de las encuestas a aplicar. ¿Qué tipo de sesgo se busca evitar?

A) Sesgo de memoria
B) Sesgo de información
C) Sesgo de confusión
D) Sesgo de notificación
E) Sesgo del entrevistador

Respuesta B. Los sesgos de información o sesgos de medida son aquellos en los que la información obtenida está sesgada. En este caso se trata de un sesgo del instrumento de medición. Ver resumen de SP o una película de terror (son iguales).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 70 · texto original del banco, sin revisar

¿Qué tipo de sesgo se trata de evitar, al validar previamente los cuestionarios en un estudio?

A) Sesgo de memoria
B) Sesgo de información
C) Sesgo de confusión
D) Sesgo de selección
E) Sesgo del entrevistador

Respuesta B. Los sesgos de información o medida se previenen con el doble ciego y con instrumentos de medición validados y calibrados.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 73 · texto original del banco, sin revisar

La erradicación del Helicobacter pylori reduce significativamente la recidiva de la úlcera gastroduodenal, en comparación a aquellos casos en que no se erradica. Este es uno de los principales argumentos para afirmar la relación causal entre esta bacteria y dicha patología. ¿A qué criterio de causalidad de Bradtford Hills corresponde?

A) Asociación
B) Relación dosis efecto
C) Plausibilidad biológica
D) Cesación de la exposición
E) Congruencia con el conocimiento científico existente

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (Cesación de la exposición). De las opciones es la única aceptable.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

7.01.3.027 Investigación epidemiológica

Dónde se enseña: Tema 21.4 Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile

QUÉ HAY QUE SABER

- Investigación de un brote en orden: confirmar el diagnóstico y la existencia del brote (más casos que lo esperado), definir caso, buscar casos, describir por persona-lugar-tiempo, plantear y probar hipótesis (casos y controles) y aplicar medidas de control.
- Brote de ETA: ≥2 casos con alimento común; curva epidémica, tasa de ataque y riesgo relativo por alimento; agentes habituales Salmonella y Staphylococcus.
- Notificar a la SEREMI de Salud (autoridad sanitaria territorial) ante el brote; no basta avisar al director del hospital.
- Medidas inmediatas: inspección sanitaria, decomiso del alimento, coprocultivos a los afectados, profilaxis de contactos cuando corresponde.
- Comunicar resultados y evaluar el control.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

La SEREMI de Salud recibe la notificación de 25 personas con diarrea y vómitos 6 a 12 horas después de asistir a un matrimonio. Se decide iniciar una investigación epidemiológica. **Tras organizar el equipo de terreno, ¿cuál es el primer paso de la investigación del brote?**

A) Publicar los resultados en la prensa
B) Confirmar el diagnóstico y verificar la existencia del brote
C) Diseñar un ensayo clínico con antibióticos
D) Calcular odds ratio antes de definir qué es un caso
E) Clausurar el local sin investigar

Respuesta B. La investigación de un brote sigue pasos ordenados: confirmar el diagnóstico y la existencia del brote (más casos que lo esperado), definir caso, buscar casos, describir según persona, lugar y tiempo, plantear y probar hipótesis (por ejemplo, con casos y controles), aplicar medidas de control y comunicar los resultados.

7.01.3.028 Pruebas de screening (tamizaje) y diagnósticas

Dónde se enseña: Tema 21.8 Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC · Tema 21.10 Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos

QUÉ HAY QUE SABER

- Sensibilidad = VP/(VP+FN); especificidad = VN/(VN+FP). Son propiedades del test y no cambian con la prevalencia. Ejemplo: 92 de 100 enfermos positivos = sensibilidad 92%.
- Tamizaje exige alta sensibilidad (un negativo descarta); confirmación exige alta especificidad (un positivo confirma). ELISA para VIH: sensible, tamizaje; Western Blot: específico, confirmatorio.
- VPP y VPN dependen de la prevalencia: prevalencia alta sube VPP y baja VPN; prevalencia baja (tamizaje masivo) baja el VPP con muchos falsos positivos y sube el VPN.
- Razón de verosimilitud (+) = S/(1−E), >10 confirma; (−) = (1−S)/E, <0,1 descarta; no dependen de la prevalencia. Curva ROC: S vs 1−E; área 0,5 es azar, >0,9 excelente.

- Tamizaje no diagnostica, clasifica a personas asintomáticas; es prevención secundaria. Programas chilenos: PAP 25-64 años cada 3 años, mamografía 50-69 años cada 3 años, tamizaje neonatal universal.

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 60

¿Cuál de las siguientes características del Elisa permite detectar a los pacientes con infección por el VIH, en la población asintomática? **Seleccione la alternativa correcta:**

A) Alta sensibilidad
B) Baja especificidad
C) Alta especificidad
D) Alto valor predictivo positivo
E) Alto valor predictivo negativo

Respuesta A. Un test de tamizaje debe detectar a todos los enfermos: necesita alta sensibilidad. Por eso un ELISA reactivo no es diagnóstico y requiere confirmación (en Chile, por el ISP).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 28

Se busca determinar la utilidad de una prueba diagnóstica. **¿Qué técnica es la más adecuada?**

A) Elaboración de curvas de ROC
B) Determinar la sensibilidad y especificidad de la prueba
C) Determinar la sensibilidad de la prueba y la prevalencia de la enfermedad
D) Determinar la especificidad y el valor predictivo negativo de la prueba
E) Determinar el número necesario para tratar (NNT)

Respuesta B. El cálculo de la sensibilidad y la especificidad es la forma clásica de determinar la utilidad de una prueba diagnóstica. Las curvas ROC también sirven, pero solo para pruebas cuantitativas, y de hecho requieren primero calcular la sensibilidad y la especificidad en distintos puntos de corte.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 43

Se pregunta por la característica obligatoria de una prueba de tamizaje. **Una prueba de tamizaje obligatoriamente debe tener:**

A) Alta especificidad, sin importar la sensibilidad
B) Alta sensibilidad, independiente de la especificidad
C) Alto valor predictivo positivo y facilidad en su aplicación
D) Bajo valor predictivo negativo y reproductibilidad
E) Bajo costo y baja sensibilidad

Respuesta B. Una prueba de tamizaje debe tener alta sensibilidad, para detectar al máximo posible de enfermos y no dejar pasar casos, aunque su especificidad no sea tan alta; los falsos positivos que genere se resuelven después con una prueba confirmatoria más específica.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 60

Se pregunta por la característica del ELISA que permite detectar a los pacientes con infección por VIH en la población asintomática. **¿Cuál de las siguientes características del ELISA permite detectar a los pacientes con infección por el VIH en la población asintomática?**

A) Alta sensibilidad
B) Baja especificidad
C) Alta especificidad
D) Alto valor predictivo positivo
E) Alto valor predictivo negativo

Respuesta A. Las pruebas de tamizaje, como el ELISA para VIH en población asintomática, requieren una alta sensibilidad para no dejar pasar casos, tolerando una especificidad intermedia; los positivos se confirman después con Western Blot, que sí exige alta especificidad.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 122

Se pregunta cuál es la mejor estrategia para la detección temprana del cáncer testicular en la población en riesgo. **¿Cuál es la mejor estrategia para la detección temprana del cáncer testicular?**

A) Niveles plasmáticos de alfafetoproteína
B) Consultorios especializados para dolor testicular
C) Campañas de autoexamen testicular
D) Ecografías testiculares como prueba de detección
E) Niveles plasmáticos de gonadotropina coriónica humana

Respuesta C. El autoexamen testicular es la estrategia que cumple los criterios de un tamizaje aplicable a toda la población en riesgo: es simple, no invasivo, de bajo costo y aceptable. La ecografía y los marcadores tumorales son exámenes diagnósticos, no herramientas de tamizaje masivo, y no se recomiendan de rutina en población asintomática.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 141 · texto original del banco, sin revisar

¿Cuál es el mejor indicador para determinar si un test de tamizaje, para la detec- ción de cáncer, es efectivo?

A) Disminución de la tasa de incidencia
B) Disminución de la tasa de prevalencia
C) Disminución de la tasa de letalidad
D) Disminución de la tasa de mortalidad
E) Aumento de la supervivencia de la enfermedad

Respuesta C. C? El tamizaje no baja la incidencia. La prevalencia baja tanto porque se mejoran, como porque se mueren. La letalidad es un buen indicador, porque al diagnosticar pre- cozmente, se evita la muerte. La mortalidad también sería un indicado bueno, menos exacta, pero más disponible.

7.01.3.029 Descripción sistemática de problemas

Dónde se enseña: Tema 21.7 Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud

QUÉ HAY QUE SABER

- Descripción sistemática de un problema de salud: responde quién (persona: edad, sexo, ocupación), dónde (lugar) y cuándo (tiempo: tendencia, estacionalidad, conglomerados).
- Cuantifica la magnitud, identifica grupos de riesgo y genera hipótesis; es la etapa previa a buscar causas.
- Ejemplo: aumento de tuberculosis en una comuna se describe antes de plantear hipótesis.
- No confundir con medidas de asociación (etapa analítica) ni con sensibilidad (evaluación de pruebas).
- Se complementa con indicadores de frecuencia: incidencia, prevalencia, mortalidad específica y letalidad.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un equipo de salud detecta un aumento de casos de tuberculosis en su comuna y decide describir sistemáticamente el problema antes de plantear hipótesis sobre su causa. **¿Qué variables utiliza la epidemiología para describir sistemáticamente un problema de salud?**

A) Persona, lugar y tiempo
B) Sensibilidad, especificidad y valores predictivos
C) Riesgo relativo, odds ratio y riesgo atribuible
D) Agente, vector y reservorio exclusivamente
E) Costo, beneficio y utilidad

Respuesta A. La descripción sistemática de un problema responde quién se enferma (persona: edad, sexo, ocupación), dónde (lugar) y cuándo (tiempo: tendencias, estacionalidad, conglomerados). Esto cuantifica su magnitud, identifica grupos de riesgo y genera hipótesis. Las medidas de asociación corresponden a la etapa analítica y la sensibilidad a la evaluación de pruebas diagnósticas.

7.01.3.030 Criterios de priorización de problemas

Dónde se enseña: Tema 21.5 Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

QUÉ HAY QUE SABER

- Criterios clásicos de priorización: magnitud (cuántos afecta: prevalencia, incidencia), trascendencia (gravedad e impacto: mortalidad, discapacidad, AVISA, costo social), vulnerabilidad (existencia de intervención eficaz) y factibilidad (recursos, aceptabilidad, viabilidad).
- Método de Hanlon: pondera magnitud, gravedad, eficacia de la solución y factibilidad.

- Se prioriza después de recolectar datos y escuchar a la comunidad en el diagnóstico participativo, no antes ni solo por prevalencia.
- La vulnerabilidad evalúa si existe una intervención eficaz que modifique el problema.
- Tras priorizar: plan de acción intersectorial con metas, indicadores y monitoreo.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Tras su diagnóstico de situación, un CESFAM debe priorizar sus problemas de salud usando criterios clásicos: magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad. **¿Qué evalúa el criterio de vulnerabilidad?**
>
> **A)** La gravedad del problema y su impacto social y económico
> **B)** El número de personas afectadas
> **C)** Si existen intervenciones eficaces capaces de modificar el problema
> **D)** La disponibilidad de recursos y la aceptación de la comunidad
> **E)** La tendencia del problema en los últimos años
>
> Respuesta C. En la priorización: magnitud es cuántos afecta (prevalencia, incidencia); trascendencia, su gravedad e impacto (mortalidad, discapacidad, años de vida perdidos, costo social); vulnerabilidad, la existencia de intervenciones eficaces para modificarlo; y factibilidad, si hay recursos, aceptabilidad y viabilidad para aplicarlas.

7.01.3.031 Estrategias de control de enfermedades infecciosas

Dónde se enseña: Tema 21.4 Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile

QUÉ HAY QUE SABER

- Control de enfermedades infecciosas: vacunación masiva (mayor impacto, inmunidad de rebaño), notificación y vigilancia, estudio y quimioprofilaxis de contactos, saneamiento básico, aislamiento y cuarentena (complementarias y transitorias).
- Quimioprofilaxis: meningococo a contactos estrechos (convivientes o saliva compartida en 10 días) con rifampicina 600 mg c/12 h por 2 días o ciprofloxacino dosis única (ceftriaxona IM en embarazadas); coqueluche, azitromicina a convivientes y cuidadores de lactantes; hantavirus no tiene profilaxis farmacológica, solo seguimiento clínico.
- Notificación inmediata ante sospecha, sin esperar laboratorio, para permitir profilaxis oportuna; la vacuna evalúa su éxito por baja de incidencia.
- Brotes de ETA: investigación, inspección y decomiso del alimento, coprocultivos.
- El médico general notifica, indica profilaxis y educa; la SEREMI conduce la investigación epidemiológica.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 56**
>
> Durante una pandemia respiratoria, el Ministerio de Salud debe decidir la intervención de salud pública con mayor impacto para reducir la mortalidad poblacional a largo plazo. **¿Cuál es la medida más eficaz?**
>
> **A)** Profilaxis antibiótica masiva
> **B)** Desinfección ambiental de espacios públicos
> **C)** Cuarentena de contactos
> **D)** Vacunación masiva de la población
> **E)** Aislamiento de casos positivos solamente
>
> Respuesta D. La vacunación masiva es la estrategia de control con mayor impacto sobre la mortalidad por infecciones respiratorias: protege al vacunado y genera inmunidad de rebaño. Cuarentena y aislamiento son medidas complementarias y transitorias; la profilaxis antibiótica no sirve contra virus.

7.01.3.032 Estrategias de control de enfermedades crónicas prioritarias (cáncer, cardiovasculares)

Dónde se enseña: Tema 1.5 Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular

QUÉ HAY QUE SABER

- Prioridades: cáncer y enfermedades cardiovasculares son primeras causas de muerte en Chile; la estrategia se basa en prevención primaria (tabaco, alimentación, actividad física), detección precoz y tratamiento oportuno (GES).

- Factores de riesgo comunes y modificables: tabaquismo, hipertensión, dislipidemia, diabetes, obesidad, sedentarismo y alcohol; abordaje poblacional (etiquetado de alimentos, ley del tabaco) más intervención individual en APS.
- Programa de Salud Cardiovascular en APS: pesquisa en el Examen de Medicina Preventiva, control por riesgo cardiovascular y metas terapéuticas con farmacoterapia GES (HTA, DM2, dislipidemia).
- Tamizaje con evidencia: PAP (25-64 años), mamografía (50-69 años), cáncer colorrectal y gástrico según programas; el tamizaje es prevención secundaria y debe evaluarse por reducción de mortalidad específica.
- Estilo de vida: ≥150 min/semana de actividad aeróbica moderada repartida en ≥3 días más ejercicios de resistencia 2-3 veces por semana; alimentación saludable y cese del tabaco.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 6

Se pregunta cuál es el mejor indicador para determinar si un programa de tamizaje del cáncer de mama es efectivo. **¿Cuál es el mejor indicador para determinar si un programa de tamizaje del cáncer de mama es efectivo?**

A) Tasa de incidencia de cáncer de mama
B) Tasa de prevalencia de cáncer de mama
C) Tasa de letalidad de cáncer de mama
D) Tasa de mortalidad de cáncer de mama
E) Tasa de positividad de las pruebas de tamizaje

Respuesta D. El indicador válido para evaluar un tamizaje es la reducción de la mortalidad. El tamizaje no reduce la incidencia, porque no evita que aparezca el cáncer, solo lo detecta antes; y la sobrevida o la letalidad calculadas desde el diagnóstico pueden estar infladas por el sesgo de adelanto o el de duración.

Pregunta de práctica

El Ministerio de Salud busca reducir la mortalidad cardiovascular del país y evalúa distintas medidas. Siguiendo a Geoffrey Rose, distingue entre estrategias dirigidas a individuos de alto riesgo y estrategias poblacionales. **¿Cuál de las siguientes corresponde a una estrategia poblacional?**

A) Realizar angioplastía precoz en el infarto agudo
B) Indicar estatinas a pacientes con riesgo cardiovascular alto
C) Ingresar a los hipertensos al Programa de Salud Cardiovascular
D) Reducir el contenido de sodio del pan mediante un acuerdo con la industria panificadora
E) Prescribir antiagregantes a pacientes con enfermedad coronaria

Respuesta D. La estrategia poblacional desplaza la distribución del factor de riesgo en toda la población, como reducir la sal del pan, la ley de etiquetado de alimentos o los impuestos al tabaco. Logra gran impacto porque la mayoría de los eventos ocurre en personas de riesgo moderado. Las demás opciones son estrategias de alto riesgo o tratamiento individual.

7.01.3.033 Bases conceptuales de la seguridad social

Dónde se enseña: Tema 21.1 Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

QUÉ HAY QUE SABER

- Seguridad social: protección que la sociedad otorga ante contingencias (enfermedad, vejez, invalidez, cesantía, muerte) mediante prestaciones y subsidios.
- Principios clásicos: universalidad (cubre a toda la población), integralidad (todas las contingencias), solidaridad (aporta según su capacidad y recibe según su necesidad; subsidio cruzado), suficiencia (prestaciones adecuadas) y unidad (coordinación administrativa).
- Modelos: Bismarck (cotización de trabajadores y empleadores), Beveridge (financiamiento por impuestos, cobertura universal).
- En Chile el sistema es mixto: cotización legal de salud de 7% de la remuneración imponible más aporte fiscal.
- La solidaridad se expresa en FONASA; en ISAPRE el plan depende del contrato individual y el riesgo.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

En un sistema de seguridad social en salud, las personas de mayores ingresos cotizan más, y los aportes de los sanos y de quienes más ganan financian la atención de los enfermos y de quienes menos tienen. **¿Qué principio de la seguridad social describe esta situación?**

A) Unidad
B) Universalidad
C) Integralidad
D) Suficiencia
E) Solidaridad

Respuesta E. Los principios clásicos de la seguridad social son: universalidad (cubre a toda la población), integralidad (cubre todas las contingencias), solidaridad (cada uno aporta según su capacidad y recibe según su necesidad), suficiencia (prestaciones adecuadas a la necesidad) y unidad (coordinación administrativa). El subsidio cruzado entre ingresos y riesgos es solidaridad.

7.01.3.034 Desarrollo histórico de seguridad social y atención de salud

Dónde se enseña: Tema 21.1 Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

QUÉ HAY QUE SABER

- Hitos históricos: 1924 Caja del Seguro Obrero Obligatorio; 1952 Servicio Nacional de Salud (SNS), que unificó la atención estatal; 1979-1981 reforma: Sistema Nacional de Servicios de Salud, FONASA e ISAPRE; 2005 comienzo del régimen GES (AUGE).
- Ley Ricarte Soto (20.850) para tratamientos de alto costo y Ley de derechos y deberes de los pacientes (20.584) son hitos posteriores.
- El SNS integró prevención y asistencia con base estatal; la reforma de 1981 introdujo la coexistencia de subsistema público y privado.
- Ley 19.966 (2004) creó el Régimen de Garantías Explícitas en Salud.
- Evolución: de seguro de obreros a cobertura universal con garantías exigibles.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

En la historia de la salud chilena, en 1952 se integraron diversos servicios asistenciales, sanitarios y de beneficencia en una única institución estatal que pasó a atender a obreros e indigentes y a desarrollar programas de salud pública a nivel nacional. **¿Qué institución se creó en ese año?**

A) El Fondo Nacional de Salud (FONASA)
B) El Servicio Nacional de Salud (SNS)
C) Las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE)
D) La Caja del Seguro Obrero Obligatorio
E) El Régimen de Garantías Explícitas en Salud

Respuesta B. En 1924 se creó la Caja del Seguro Obrero Obligatorio; en 1952, el Servicio Nacional de Salud, que unificó la atención estatal. A partir de 1979 y 1981 se reorganizó el sistema, creando el Sistema Nacional de Servicios de Salud, FONASA y las ISAPRE. En 2005 comenzó el régimen GES (AUGE).

7.01.3.035 Funciones de los sistemas de atención de salud

Dónde se enseña: Tema 21.1 Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

QUÉ HAY QUE SABER

- Funciones de los sistemas de salud: rectoría (conducción, políticas, normas y fiscalización), financiamiento, aseguramiento y provisión de servicios; la generación de recursos (personal, infraestructura) sostiene las anteriores.
- En Chile: rectoría del MINSAL (con subsecretarías y SEREMI); financiamiento y aseguramiento por FONASA e ISAPRE; provisión por la red de Servicios de Salud y prestadores privados.
- La Superintendencia de Salud fiscaliza a FONASA, ISAPRE y prestadores, y vela por el cumplimiento de las garantías GES.
- El ISP es el laboratorio nacional de referencia y regula medicamentos; no fiscaliza el dinero.
- Pregunta tipo: quien ejerce la rectoría es el Ministerio de Salud, no FONASA ni los Servicios de Salud.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Según la OMS, todo sistema de salud cumple funciones de rectoría, financiamiento, aseguramiento y provisión de servicios. En Chile, estas funciones están separadas entre distintas instituciones. **¿Qué institución ejerce la función de rectoría del sistema de salud chileno?**

A) Los Servicios de Salud
B) El Fondo Nacional de Salud (FONASA)
C) El Ministerio de Salud
D) La Superintendencia de Salud
E) La Central de Abastecimiento (CENABAST)

Respuesta C. La rectoría (conducción, formulación de políticas y normas) corresponde al Ministerio de Salud, a través de sus subsecretarías y las SEREMI. FONASA ejerce el financiamiento y aseguramiento público; los Servicios de Salud gestionan la red asistencial que provee las prestaciones; la Superintendencia fiscaliza a FONASA, ISAPRE y prestadores; y CENABAST abastece de fármacos e insumos.

7.01.3.036 Organización actual del sistema de salud chileno

Dónde se enseña: Tema 21.1 Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

QUÉ HAY QUE SABER

- MINSAL rector y normativo, con Subsecretaría de Salud Pública (vigilancia epidemiológica y SEREMI) y Subsecretaría de Redes Asistenciales (gestiona los Servicios de Salud). Superintendencia de Salud: autónoma, fiscaliza.
- Dos subsistemas: FONASA (seguro público, solidario, mayoría de la población) e ISAPRES (seguros privados con plan individual); también FFAA con su propio sistema.
- FONASA tramos A, B, C y D según ingreso del grupo familiar; tramo A sin derecho a Modalidad Libre Elección; con Copago Cero (2022) los cuatro tramos tienen gratuidad total en Modalidad de Atención Institucional.
- Financiamiento: cotización 7% más aporte fiscal; la APS municipal se financia con aporte per cápita que financia el Plan de Salud Familiar.
- Red asistencial en tres niveles: primario (CESFAM, CECOSF, postas rurales; resuelve 80-90% de consultas), secundario (CDT, CAE, COSAM) y terciario (hospitales de alta complejidad).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 126

Una empresa extranjera dedicada a otorgar prestaciones en salud decide iniciar sus operaciones en Chile, para lo cual solicita saber cuál es la institución que actúa como laboratorio de referencia para todos los laboratorios, tanto públicos como privados, en el país. **¿Cuál es la respuesta correcta?**

A) Central Nacional de Abastecimiento
B) Instituto de Salud Pública
C) Superintendencia de Salud
D) Servicio Médico Legal
E) Secretaría Regional Ministerial de Salud

Respuesta B. El Instituto de Salud Pública actúa como laboratorio nacional y de referencia, supervisa laboratorios de exámenes médicos y de producción de medicamentos, autoriza y fiscaliza medicamentos y dispositivos médicos, y realiza vigilancia sanitaria y epidemiológica de laboratorio.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 129

¿Cuál de las siguientes instituciones es la encargada de supervisar el funcionamiento del sistema de salud público y privado en Chile, fiscalizar a FONASA y a las instituciones previsionales de salud, y velar por el cumplimiento de las garantías GES? **¿Cuál es la institución correcta?**

A) Instituto de Salud Pública
B) Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud
C) Ministerio de Salud, por medio de la Subsecretaría de Salud Pública
D) Superintendencia de Salud
E) Fondo Nacional de Salud (FONASA)

Respuesta D. La Superintendencia de Salud es el organismo autónomo encargado de supervisar y fiscalizar tanto al sistema público como privado, incluyendo a FONASA, a las ISAPRES y el cumplimiento de las garantías GES.

7.01.3.037 Política sanitaria y objetivos sanitarios en Chile

Dónde se enseña: Tema 21.1 Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

QUÉ HAY QUE SABER

- Política sanitaria: se formaliza en los Objetivos Sanitarios de la Década, plasmados en la Estrategia Nacional de Salud, que fija ejes, metas de impacto e indicadores del período y orienta la planificación de la red.
- Los objetivos se miden con indicadores de impacto (mortalidad, esperanza de vida, discapacidad) y de equidad.
- Instrumentos relacionados: GES (garantías), Ley Ricarte Soto, Programa de Inmunizaciones, planes de salud comunal.
- El Código Sanitario regula materias sanitarias; no contiene los objetivos sanitarios.
- Rectoría y definición de políticas: MINSAL; ejecución por Servicios de Salud y APS municipal.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

El Ministerio de Salud define, para el período 2021-2030, los objetivos de impacto que el país espera lograr en salud de la población, junto con sus metas e indicadores, para orientar la planificación de toda la red. **¿Qué instrumento contiene estos objetivos sanitarios?**

A) El arancel de FONASA
B) La Ley Ricarte Soto
C) El Código Sanitario
D) El Plan de Salud Comunal
E) La Estrategia Nacional de Salud

Respuesta E. Los Objetivos Sanitarios de la Década se formalizan en la Estrategia Nacional de Salud, que fija ejes estratégicos, metas de impacto e indicadores para el período y orienta la planificación de la red. El Código Sanitario regula materias sanitarias, la Ley Ricarte Soto financia tratamientos de alto costo y el Plan Comunal es la programación local.

7.01.3.038 Definición, estructura y funciones de los subsistemas en Chile

Dónde se enseña: Tema 21.1 Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

QUÉ HAY QUE SABER

- FONASA: seguro público; modalidad de atención institucional (red pública, gratuita en los 4 tramos desde Copago Cero) y modalidad Libre Elección (bonos en privados en convenio; tramo A no accede).
- ISAPRES: seguros privados con contrato individual y plan de salud según ingreso y riesgo; tienen GES con tope de copago 20% y deducible anual.
- Servicios de Salud: organismos descentralizados que gestionan la red pública asistencial de un territorio; APS municipal con CESFAM, CECOSF y postas.
- Superintendencia de Salud: autónoma, fiscaliza FONASA, ISAPRES y prestadores; la acreditación de prestadores y el Registro Nacional de Prestadores Individuales dependen de ella.
- SEREMI: autoridad sanitaria regional, autoriza el funcionamiento sanitario de establecimientos y conduce la vigilancia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 95 · texto original del banco, sin revisar

Las instituciones de salud previsional y el seguro público de salud tienen en salud que:

A) Administrar el seguro de cotización individual
B) Administran el seguro público de salud
C) Administrar los fondos para las garantías de salud, comprendidas en el plan AUGE
D) Administran el seguro general de salud
E) Dan prestaciones de salud

Respuesta C. Tanto las Isapres, como Fonasa administran los fondos AUGE. Las Isapres adminstran el seguro de cotización individual y Fonasa el seguro público. No sé qué es el seguro general. Ninguna dan prestaciones de salud, porque son seguros, no prestadores,

7.01.3.039 Concepto y descripción de la red asistencial chilena

Dónde se enseña: Tema 21.1 Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

QUÉ HAY QUE SABER

- Red asistencial pública en tres niveles: primario (CESFAM, CECOSF, postas rurales, SAPU, SAR; puerta de entrada obligatoria; resuelve 80-90% de las consultas), secundario (especialidad ambulatoria, CDT, CAE, COSAM) y terciario (hospitales de alta complejidad con camas críticas y cirugía mayor).
- Se accede al nivel secundario por interconsulta oficial desde APS, no por decisión directa del paciente.
- SAPU: urgencia básica adosada al CESFAM, tardes, noches y festivos, con electrocardiograma y laboratorio rápido. SAR: más resolutivo, 24 h o extendido, con radiografía digital y laboratorio con troponina y dímero D.
- COSAM (salud mental ambulatoria) es nivel secundario; CESFAM, CECOSF, posta rural y hospital comunitario son de APS.
- Referencia (hacia mayor complejidad) y contrarreferencia (retorno a APS) aseguran la continuidad del cuidado.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 166

Un médico recién llegado a un Servicio de Salud debe conocer el nivel de atención de los establecimientos de su red asistencial para derivar correctamente a sus pacientes. **¿Cuál de los siguientes corresponde a un centro de atención secundaria?**

A) CESFAM
B) CECOSF
C) Posta de salud rural
D) Hospital comunitario de familia
E) COSAM

Respuesta E. El COSAM es un centro de especialidad ambulatoria en salud mental, por lo que pertenece al nivel secundario. CESFAM, CECOSF, posta de salud rural y hospital comunitario de salud familiar son establecimientos de atención primaria.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 31 · texto original del banco, sin revisar

¿Cuál de las siguientes instituciones corresponde a un centro de salud secundaria?

A) Posta de Salud Rural
B) CESFAM (Centro de Salud Familiar)
C) COSAM (Centro de Salud Mental)
D) CECOSF (Centro Comunitario de Salud Familiar)
E) Hospital comunitario

Respuesta A. Diagnóstico: Posta de Salud Rural (opción A). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

7.01.3.040 Beneficios de la seguridad social y rol del médico en su acceso

Dónde se enseña: Tema 21.2 Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos · Tema 21.3 Ley Ricarte Soto (Tratamientos de Alto Costo) y Programas Alimentarios Nacionales (PNAC y PACAM)

QUÉ HAY QUE SABER

- Beneficios de la seguridad social en salud: GES (87 problemas con 4 garantías de acceso, oportunidad, protección financiera y calidad), Ley Ricarte Soto (alto costo, cobertura universal y copago 0), Copago Cero en FONASA, PNAC y PACAM, licencia médica y subsidio.
- Rol del médico: informar y dejar constancia de la sospecha o confirmación GES en el Formulario de Constancia firmado por médico y paciente (no hacerlo es falta grave sancionable por la Superintendencia); tramitar derivación a especialista tratante para Ricarte Soto.
- Si se vence el plazo GES: reclamo escrito del paciente al asegurador dentro de 30 días; el asegurador tiene 48 h hábiles para designar segundo prestador (10 días corridos, hasta 30 en complejas); si falla, Superintendencia designa tercer prestador en 48 h hábiles a costo del asegurador.
- Garantía de protección financiera: copago tope 20% en ISAPRE (0% en FONASA) y deducible anual; Ricarte Soto y PNAC son universales, sin importar la previsión.
- PACAM: ≥70 años FONASA con EMPAM y vacunas al día, sin evaluación socioeconómica ni certificado de desnutrición.

PREGUNTAS (3)

Pregunta de práctica

Un paciente de 64 años con diagnóstico confirmado de artrosis de cadera con indicación de endoprótesis total (Problema GES N.° 37) tiene su plazo legal de tratamiento quirúrgico vencido por más de 15 días en el hospital público correspondiente. **¿Cuál es la conducta correcta que debe seguir el paciente?**

A) Presentar un reclamo formal por incumplimiento de Garantía de Oportunidad ante FONASA, que dispondrá de 48 horas para designar un segundo prestador
B) Acudir directamente a un tribunal civil para interponer un recurso de protección contra el hospital
C) Operarse en una clínica privada de forma autónoma y exigir el reembolso del 100% de la cuenta
D) Ingresar una solicitud de mediación prejudicial ante el Consejo de Defensa del Estado
E) Exigir al director del hospital una compensación económica diaria por cada día de retraso

Respuesta A. Ante el vencimiento del plazo de la Garantía de Oportunidad, la Ley 19.966 establece la vía administrativa: reclamo ante el asegurador, que tiene 48 horas hábiles para designar un segundo prestador que otorgue la prestación dentro de 10 días corridos.

Pregunta de práctica

Una paciente de 42 años diagnosticada de artritis reumatoide refractaria a metotrexato y leflunomida requiere inicio de un fármaco biológico de alto costo (adalimumab) contemplado en el decreto de la Ley Ricarte Soto. La paciente se encuentra afiliada a una ISAPRE. **¿Cuál es la cobertura financiera que le corresponde según la ley?**

A) Cien por ciento de cobertura gratuita financiada por el Estado, sin importar su previsión de salud
B) Ochenta por ciento de cobertura con un copago del veinte por ciento con cargo al deducible GES de su plan
C) Cincuenta por ciento de financiamiento si sus ingresos familiares superan un cierto tope
D) La Ley Ricarte Soto solo rige para afiliados a FONASA, por lo que la ISAPRE debe financiarlo con un seguro catastrófico
E) Debe pagar la totalidad del fármaco y solicitar un reembolso anual con tope ante el Ministerio de Hacienda

Respuesta A. La Ley 20.850 tiene cobertura universal para todos los habitantes del país que cumplan los criterios clínicos del decreto, sin distinción de previsión de salud, y la cobertura es totalmente gratuita para el beneficiario.

Pregunta de práctica

Un hombre de 38 años, afiliado a una ISAPRE, es diagnosticado con hipertensión arterial pulmonar grave, patología incluida en el decreto de la Ley Ricarte Soto. Su médico especialista indica un tratamiento vasodilatador específico de alto costo, disponible en un centro acreditado por el MINSAL. **¿Cuál es la cobertura financiera que le corresponde a este paciente?**

A) Cien por ciento de cobertura, sin copago, financiada por el Estado
B) Ochenta por ciento de cobertura, con veinte por ciento de copago según su plan de ISAPRE
C) Cobertura solo si renuncia a su ISAPRE y se afilia a FONASA
D) Cincuenta por ciento de cobertura si supera el deducible anual de su plan
E) Debe pagar el tratamiento y solicitar reembolso posterior a su ISAPRE

Respuesta A. La Ley Ricarte Soto cubre de forma universal, sin importar la previsión, y con financiamiento 100% estatal, sin copago, para todo paciente que cumpla el criterio clínico del decreto, siempre que se trate por un especialista en un centro acreditado.

7.01.3.041 Conceptos de administración y gestión

Dónde se enseña: sp-15

QUÉ HAY QUE SABER

- Administración: proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar recursos para lograr los objetivos de una organización; gestión es su aplicación para obtener resultados (eficacia, eficiencia, efectividad).
- Eficacia: logro de objetivos; eficiencia: relación entre resultados y recursos usados; efectividad: logro del objetivo en condiciones reales; equidad y calidad como atributos de los servicios de salud.
- Niveles de gestión: estratégico (directivo), táctico (intermedio) y operativo (equipos clínicos); en la red pública, Servicios de Salud, hospitales (autogestionados) y APS municipal.
- Ciclo administrativo: planificación, organización, dirección y control/evaluación.
- El médico general participa en la gestión clínica: uso racional de recursos, metas sanitarias, registro y calidad.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Dos CESFAM implementan el mismo programa de control de hipertensión y ambos logran que el 70% de sus pacientes alcance la meta de presión arterial. Sin embargo, el CESFAM A lo consigue con la mitad del costo y de horas profesionales que el CESFAM B. **¿Qué atributo de gestión es mayor en el CESFAM A?**

A) Eficacia
B) Equidad
C) Efectividad
D) Eficiencia
E) Cobertura

Respuesta D. Eficacia es lograr el resultado en condiciones ideales; efectividad, lograrlo en condiciones reales; y eficiencia, la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados. Ambos centros tienen igual efectividad, pero el A obtiene el mismo resultado con menos recursos, por lo que es más eficiente.

7.01.3.042 Planificación y programación en salud

Dónde se enseña: sp-15

QUÉ HAY QUE SABER

- Planificación: definir diagnóstico, objetivos, metas, actividades, recursos y plazos; es el primer momento del ciclo administrativo.
- Niveles: estratégica (largo plazo), táctica o programación (mediano) y operativa (corto, plan anual); en salud se parte del diagnóstico de situación y la priorización de problemas.
- Programación: traducir los objetivos en actividades, rendimientos, recursos y cronograma, con responsables e indicadores.
- Objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes, con plazo); metas cuantificadas con indicadores.
- En Chile: Objetivos Sanitarios, Estrategia Nacional de Salud, planes de salud comunales y metas sanitarias de APS.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 4

En la gestión de salud se distinguen distintos niveles de planificación de las acciones. **En gestión de salud, ¿cuál es la diferencia entre planificación y programación?**

A) La planificación se refiere a objetivos y recursos específicos, mientras que la programación es global
B) La planificación es a largo plazo, mientras que la programación es anual
C) La programación, a diferencia de la planificación, debe ser concordante con la misión y la visión de la institución
D) La planificación se basa en lo determinado con la programación
E) La planificación se relaciona con los costos y recursos de actividades concretas y la programación con el presupuesto general del proyecto

Respuesta B. La planificación es el proceso global y estratégico, a mediano o largo plazo, que define objetivos y prioridades. La programación la operacionaliza en el corto plazo, habitualmente anual, detallando actividades, metas, recursos y responsables. Por eso la programación deriva de la planificación, y no al revés.

7.01.3.043 Formulación de programas

Dónde se enseña: sp-15

QUÉ HAY QUE SABER

- Programa de salud: conjunto organizado de actividades para resolver un problema priorizado en una población objetivo, con objetivos, metas, recursos y evaluación.
- Formulación: diagnóstico y priorización del problema, definición de población objetivo, objetivos general y específicos, metas, actividades, recursos, cronograma, responsables e indicadores de evaluación.
- Evaluación según estructura, proceso, resultado e impacto: cobertura y tiempos de atención son indicadores de proceso; la mortalidad específica es indicador de impacto.
- Criterios de priorización: magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad.
- Ejemplos de programas nacionales: Inmunizaciones, PNAC, Salud Cardiovascular, Chile Crece Contigo.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un CESFAM formula su programa de inmunizaciones de invierno. Entre sus componentes escribe: vacunar contra la influenza al 85% de los adultos de 65 años y más inscritos, antes del 30 de junio. **¿A qué componente del programa corresponde este enunciado?**

A) Misión institucional
B) Objetivo general
C) Actividad
D) Meta
E) Diagnóstico

Respuesta D. Un programa se formula con diagnóstico, objetivos (general y específicos), metas, actividades, recursos y evaluación. La meta es un objetivo cuantificado en magnitud, plazo y población: cuánto, a quiénes y para cuándo. El objetivo general es más amplio (reducir la morbimortalidad por influenza) y la actividad es la acción concreta (vacunar en operativos).

7.01.3.044 Organización: principios y características estructurales y funcionales de las organizaciones

Dónde se enseña: sp-15

QUÉ HAY QUE SABER

- Organización: estructura formal que divide el trabajo y coordina funciones para lograr objetivos; principios clásicos: división del trabajo, jerarquía o cadena de mando, unidad de mando, autoridad y responsabilidad, especialización y coordinación.
- Estructura: organigrama; tipos lineal, funcional, matricial; centralización vs descentralización; amplitud de control.
- Organización formal (definida por estatutos) vs informal (relaciones espontáneas del grupo).
- En salud: Servicios de Salud con hospitales autogestionados, direcciones de APS municipales y equipos de cabecera por sector.
- Una organización eficaz define claramente cargos, funciones, flujos de comunicación y responsables.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

En un hospital, los técnicos en enfermería de un servicio reciben instrucciones contradictorias de la enfermera supervisora, del jefe de servicio y del jefe de turno médico, lo que genera confusión y errores. **¿Qué principio de la organización se está vulnerando?**

A) Delegación de autoridad
B) Tramo de control
C) Descentralización
D) Especialización
E) Unidad de mando

Respuesta E. La unidad de mando establece que cada trabajador debe recibir órdenes de un solo jefe directo, para evitar instrucciones contradictorias. El tramo de control se refiere al número de subordinados que un jefe puede dirigir eficazmente; la delegación, a transferir autoridad hacia niveles inferiores; y la especialización, a la división del trabajo.

7.01.3.045 Dirección: funciones de la dirección, liderazgo, comunicaciones, coordinación

Dónde se enseña: sp-15

QUÉ HAY QUE SABER

- Dirección: guiar al equipo hacia los objetivos mediante liderazgo, motivación, comunicación y coordinación; es el momento de ejecución del ciclo administrativo.
- Liderazgo: autocrático, democrático o participativo, y laissez-faire; el líder en salud promueve trabajo en equipo y toma de decisiones compartidas.
- Comunicación efectiva: clara, bidireccional, oportuna y con retroalimentación; barreras: ruido, jerarquía, falta de información.
- Coordinación: articula actividades entre áreas y niveles de la red para evitar duplicidad.
- Motivación y manejo de conflictos son funciones directivas; la delegación con responsabilidad aumenta la eficiencia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 120

Se produce un accidente de tránsito de alta energía fuera del horario laboral, en el que un grupo de pacientes resulta lesionado de gravedad. Son trasladados al servicio de urgencia, donde los recibe el médico de turno y son hospitalizados para su tratamiento médico y quirúrgico. La prensa exige información inmediata sobre el estado de los pacientes. **¿Quién debe realizar esta comunicación?**

A) El médico de turno
B) El director del hospital
C) El encargado de relaciones públicas del hospital
D) La enfermera jefe del servicio de urgencia
E) El personal administrativo del hospital

Respuesta B. La comunicación oficial de la institución hacia los medios es una función de la dirección: corresponde al director del hospital o a quien él designe como vocero, resguardando la confidencialidad de los pacientes (Ley 20.584). El médico de turno informa a los pacientes y familiares, no a la prensa; relaciones públicas apoya, pero no es la autoridad.

7.01.3.046 Evaluación y control: conceptos, tipos de evaluación

Dónde se enseña: Tema 21.10 Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos

QUÉ HAY QUE SABER

- Evaluación: compara lo logrado con lo planificado; control: corrige desviaciones. Tipos según momento: ex ante, concurrente (monitoreo) y ex post.
- Según componente: estructura (recursos), proceso (actividades; cobertura, tiempos de atención), resultado e impacto (cambio final en salud de la población; mortalidad específica).
- Eficacia (logro de objetivos), efectividad (en condiciones reales) y eficiencia (resultados en relación con recursos).
- Ejemplo: en un programa de detección precoz de cáncer de mama, la mortalidad específica es el indicador de impacto; en tamizaje se desconfía de sobrevida a 5 años por sesgo de adelanto y de duración.
- Tamizaje: criterios de Wilson y Jungner (problema importante, fase preclínica prolongada, test simple y de alta sensibilidad, tratamiento eficaz que rinde más en fase precoz, costo razonable, proceso continuo).

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 118

En un programa de detección precoz de cáncer de mama se mide periódicamente la tasa de mortalidad específica por esta enfermedad. **¿Qué función cumple la medición de la tasa de mortalidad específica por dicha enfermedad?**

A) Permite determinar el grado de cobertura del programa
B) Contribuye a evaluar la calidad del proceso de atención en el programa
C) Permite obtener una variable indirecta que refleja la efectividad del programa
D) Permite evaluar la eficiencia del proceso de aplicación del programa
E) Refleja el impacto del programa

Respuesta E. La evaluación de programas distingue estructura, proceso, resultado e impacto. La mortalidad específica por cáncer de mama es el indicador de impacto del tamizaje, porque mide el cambio final en la salud de la población, que es su objetivo. La cobertura y los tiempos de atención son indicadores de proceso; la eficiencia relaciona resultados con recursos.

7.01.3.047 Auditoría y acreditación

Dónde se enseña: Tema 21.2 Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos

QUÉ HAY QUE SABER

- Acreditación: proceso periódico, formal y externo de evaluación de la calidad y seguridad del paciente en prestadores institucionales; la realiza la Superintendencia de Salud (Intendencia de Prestadores), con entidades acreditadoras.
- Es el mecanismo de exigibilidad de la garantía de calidad GES: solo profesionales inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales y establecimientos acreditados pueden otorgar prestaciones GES.
- Autorización sanitaria de funcionamiento: la otorga la SEREMI de Salud; no es lo mismo que acreditar.
- Un prestador no acreditado que otorga una prestación GES vulnera la garantía de calidad aunque la atención clínica sea buena.

- Auditoría: revisión sistemática e independiente de procesos o registros (clínicos, financieros) para verificar cumplimiento de normas y proponer mejoras.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 18

¿A qué tipo de garantía corresponde el registro de los profesionales de la salud en el Registro de Prestadores Individuales, llevado por la Superintendencia de Salud, en contexto del programa de Garantías Explícitas de Salud (GES)? **¿Cuál es la garantía correcta?**

A) Garantía de acceso universal
B) Garantía de protección financiera
C) Garantía de calidad en la atención
D) Garantía de oportunidad en la atención
E) Garantía de acceso a la información

Respuesta C. El registro de prestadores individuales y la acreditación de prestadores institucionales ante la Superintendencia de Salud son el mecanismo de exigibilidad de la Garantía de Calidad. El acceso a la información no forma parte de las cuatro garantías GES.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 96

En el sistema de salud chileno existen instituciones encargadas de garantizar la calidad de los prestadores. **¿Qué institución es la encargada de acreditar y autorizar a los prestadores individuales de salud y a los centros de salud?**

A) La Superintendencia de Seguridad Social
B) La autoridad regional sanitaria
C) La Superintendencia de Salud
D) FONASA
E) La municipalidad

Respuesta C. La Superintendencia de Salud, a través de su Intendencia de Prestadores, acredita a los prestadores institucionales y lleva el Registro Nacional de Prestadores Individuales, ambos parte de la garantía de calidad GES. La autorización sanitaria de funcionamiento de un establecimiento la otorga la SEREMI de Salud, por lo que el enunciado mezcla ambos conceptos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 82 · texto original del banco, sin revisar

¿Cuál de las siguiente actividades o medidas, está relacionado con el principio de ca- lidad de las garantías explícitas de salud (GES)?:

A) Autorización sanitaria de prestadores y laboratorios
B) Certificación por parte de la superintendencia de los prestadores de salud
C) Vigilancia del cumplimiento de plazos
D) Convenios entre ISAPRES y prestadores de salud
E) Vigilancia epidemiológica

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Certificación por parte de la superintendencia de los prestadores de salud). La certificación asegura que el prestador cumple con los estándares de calidad.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

7.01.3.049 Financiamiento del sector salud

Dónde se enseña: Tema 21.1 Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

QUÉ HAY QUE SABER

- Fuentes: cotización legal de salud de 7% de la remuneración imponible (dependientes, independientes y pensionados) más aporte fiscal general, que financia especialmente a los tramos de menores ingresos y la infraestructura pública.
- FONASA tramos A, B, C y D según ingreso; con Copago Cero (desde 2022) la atención institucional en red pública es gratuita en los cuatro tramos; el tramo A no tiene Libre Elección.
- APS municipal: aporte per cápita por persona inscrita y validada, que financia el Plan de Salud Familiar, con aportes municipales complementarios.
- GES: protección financiera con copago 0% en FONASA y tope 20% en ISAPRE, con deducible anual máximo por problema de salud.
- Ley Ricarte Soto: financiamiento 100% estatal, universal, sin copago ni deducible.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 128

La atención primaria municipal entrega a su población inscrita el Plan de Salud Familiar, una canasta de prestaciones para el niño, la mujer, el adulto y el adulto mayor. **¿Cómo se financia el Plan de Salud Familiar, ofrecido por el sistema de atención primaria de salud de Chile?**

A) Transferencias por prestaciones otorgadas
B) Aportes de fondos municipales
C) Transferencias por plan de salud
D) Aporte per cápita, en razón del número de inscritos
E) Copago de los usuarios

Respuesta D. La atención primaria municipal se financia principalmente con el aporte per cápita, un monto fijo por cada persona inscrita y validada en el establecimiento, que financia el Plan de Salud Familiar. Los aportes municipales son complementarios y no hay copago en la red pública.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 94 · texto original del banco, sin revisar

¿Cómo se financia el seguro público de salud?

A) El aporte estatal, desde los impuestos generales
B) El aporte tripartito del estado, los empleadores y trabajadores
C) El aporte de las mutuales
D) El 7% de los trabajadores
E) El aporte de los empleadores

Respuesta A. Fonasa se financia por el aporte estatal (el estado se financia por los impuestos). En segundo lugar por el aporte de los trabajadores. Los empleadores no aportan.

7.01.3.050 Rol del médico en la generación y uso de la información

Dónde se enseña: Tema 21.13 Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

QUÉ HAY QUE SABER

- El médico es generador y usuario de información: ficha clínica, certificado de defunción, notificación de enfermedades, licencias médicas y registros estadísticos (REM) alimentan las estadísticas vitales del DEIS-MINSAL y del INE.
- La calidad del llenado condiciona el diagnóstico de situación: el certificado de defunción es la fuente primaria de las estadísticas de mortalidad.
- Ficha clínica: propiedad del paciente; el establecimiento es custodio y debe conservarla al menos 15 años desde la última atención.
- Notificar enfermedades en Epivigila: inmediata o diaria según el decreto; omitir es infracción sanitaria.
- Usar los datos para decidir: priorizar problemas, evaluar programas y guiar la práctica clínica; respetar siempre la confidencialidad.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Paciente de 74 años con diabetes mellitus tipo 2 de 20 años de evolución, que desarrolló enfermedad renal crónica terminal. Fallece por una hiperkalemia grave que le produjo un paro cardiorrespiratorio. El médico debe llenar el certificado de defunción. **¿Cuál debe registrarse como causa básica de muerte?**

A) Diabetes mellitus tipo 2
B) Paro cardiorrespiratorio
C) Hiperkalemia
D) Enfermedad renal crónica
E) Vejez

Respuesta A. La causa básica es la enfermedad que inició la cadena de acontecimientos que llevó a la muerte, y es la que se usa en las estadísticas de mortalidad. Se anota en la última línea de la parte I, con las causas intermedias y la inmediata por encima. El paro cardiorrespiratorio es un mecanismo, no una causa, y no debe registrarse.

7.01.3.051 Certificado de defunción, licencia médica, notificación de enfermedades

Dónde se enseña: Tema 21.4 Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile · Tema 21.13 Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

QUÉ HAY QUE SABER

- Certificado de defunción: cadena de causas (inmediata, intermedia y básica); la básica se tabula. Nunca anotar paro cardiorrespiratorio ni falla multiorgánica como causa única o básica (mecanismos universales).
- El médico clínico firma solo si la muerte es natural por enfermedad conocida; en muerte violenta (homicidio, suicidio, accidente), intoxicación, bajo custodia, muerte quirúrgica inexplicable o cadáver hallado sin causa clara, no firma: preserva el cuerpo y notifica a Carabineros, PDI o Ministerio Público (SML); si el origen fue violento sigue siendo médico-legal aunque muera semanas después.
- Autopsia clínica: causas naturales, exige consentimiento familiar; médico-legal: la ordena el fiscal, la familia no puede oponerse y firma el médico legista.
- Licencia médica: certifica incapacidad laboral transitoria y la COMPIN autoriza, reduce o rechaza; la licencia falsa o sin evaluación clínica es delito (presidio, multa 50-500 UTM, inhabilitación).
- Notificación obligatoria (DS N°7): inmediata ante sospecha (meningococo, hantavirus, sarampión, cólera, brotes de ETA) y dentro de 24 h para TBC, sífilis, gonorrea, VIH, hepatitis virales y coqueluche; deber de denunciar delitos en 24 h.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 4

Un paciente con antecedente de cáncer de próstata sufre un tromboembolismo pulmonar, luego falla respiratoria, luego un paro cardíaco, y finalmente la muerte. **¿Cuál es la causa inmediata de muerte en el certificado de defunción?**

A) Cáncer de próstata
B) Tromboembolismo pulmonar
C) Paro cardíaco
D) Falla respiratoria
E) Trombosis venosa profunda

Respuesta D. La cadena completa es: cáncer de próstata como causa básica, tromboembolismo pulmonar como causa intermedia, y falla respiratoria como causa inmediata, la condición final antes de morir. El paro cardíaco es el mecanismo terminal universal y nunca se escribe en el certificado, por más que sea literalmente lo último que ocurrió.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 52 · texto original del banco, sin revisar

Si detecto una infección que debe tener notificación obligatoria inmediata. Conducta:

A) Avisar al delegado de epidemiología
B) Notificar inmediatamente a la SEREMI
C) Reportar en plataforma digital durante las primeras 24 hrs
D) Staphylococcus aureus
E) Streptococcus pneumoniae

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Notificar inmediatamente a la SEREMI (opción B). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 145 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 80 años, con antecedente de cáncer de próstata avanzado, en tratamiento con hormonoterapia, presenta deterioro súbito del estado respiratorio, evolucionando con taquicardia y desaturación arterial. Se solicita angioTAC, que demuestra un tromboembolismo pulmonar derecho, por lo que se inicia terapia anticoagulante, sin embargo, evoluciona en malas condiciones generales, cayendo en insuficiencia respiratoria, colapso circulatorio y, finalmente, ausencia de pulso y respiración, por lo que se realiza reanimación avanzada, con múltiples desfibrilaciones y adrenalina, sin respuesta, por lo que se declara la muerte. ¿Cuál de las siguientes debe ser la causa de muerte inmediata en el certificado de defunción?

A) Cáncer de próstata
B) Insuficiencia respiratoria aguda
C) Tromboembolismo pulmonar
D) Falla multiorgánica
E) Fibrilación ventricular

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Tromboembolismo pulmonar (opción C). El TEP masivo con compromiso hemodinámico tiene estudio y tratamiento completamente diferentes De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

7.01.3.052 Ejercicio profesional: marcos ético, legal y gremial

Dónde se enseña: Tema 21.11 Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento · Tema 21.13 Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia · Tema 21.14 Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030,

Código Sanitario y Licencias Médicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Marco legal: el Código Sanitario regula el ejercicio de las profesiones de salud (art. 112 exige título de médico cirujano; art. 113 define el acto médico); ejercer sin título es delito (ejercicio ilegal). El Código de Ética del Colegio Médico es gremial y solo obliga a los colegiados.
- Bioética (Beauchamp y Childress): autonomía, no maleficencia (prioridad sobre beneficencia), beneficencia y justicia. Consentimiento informado: información, comprensión, voluntariedad y capacidad; excepciones: urgencia vital y riesgo para la salud pública.
- Adulto competente que rechaza transfusión: se respeta con constancia escrita y se ofrecen alternativas; menor con riesgo vital: se transfunde igual y se recurre al tribunal de familia después; doble efecto en paliativos justificado por la intención de aliviar, no de matar.
- Comité de Ética Asistencial: consultivo y no vinculante; una urgencia vital nunca se demora esperándolo.
- Deber de denuncia en 24 h (Fiscalía, PDI o Carabineros) de lesiones por delito, agresión sexual, maltrato infantil y VIF grave; omitirla es delito. Interrupción del embarazo (Ley 21.030): tres causales; objeción de conciencia se suspende en riesgo vital sin otro médico disponible.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 167

Un médico recién titulado quiere conocer qué norma regula en Chile el ejercicio de las profesiones de la salud, incluida la medicina. **¿Cuál es el cuerpo normativo que regula el ejercicio de la profesión médica en Chile?**

A) Constitución Política de la República
B) Código del Colegio Médico de Chile
C) Ley que crea el Ministerio de Salud
D) Ley de Derechos y Deberes del Paciente
E) Código Sanitario

Respuesta E. El Código Sanitario regula el ejercicio de las profesiones de la salud, además del control de enfermedades transmisibles, medicamentos y establecimientos, con fiscalización de la SEREMI de Salud. El Código de Ética del Colegio Médico es gremial y solo obliga a sus colegiados; la Ley 20.584 regula los derechos del paciente.

Pregunta de práctica

Niño de 7 años politraumatizado ingresa con shock hipovolémico grado IV por rotura esplénica y hemoperitoneo crítico, hemoglobina de 4,2. El cirujano indica laparotomía urgente y transfusión inmediata. Ambos padres, testigos de Jehová, prohíben la transfusión de sangre a su hijo por motivos religiosos. **¿Cuál es la conducta médica y médico-legal correcta?**

A) Respetar la decisión de los padres y no transfundir
B) Transfundir y operar de inmediato, e interponer una medida de protección
C) Esperar la autorización de un juez antes de intervenir
D) Solicitar una segunda opinión de otro cirujano antes de decidir
E) Convocar al Comité de Ética Asistencial antes de intervenir

Respuesta B. Ante un menor con riesgo vital inminente, la autonomía de los padres se subordina al derecho a la vida y al interés superior del niño. El médico debe transfundir y operar de inmediato, y recién después interponer una medida de protección ante el tribunal de familia para respaldar jurídicamente el procedimiento; ni esperar a un juez ni convocar al comité de ética son opciones válidas cuando la vida corre riesgo inmediato.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 64 · texto original del banco, sin revisar

Durante una evaluación de calidad en un hospital se constata que un anestesista, en conjunto con un técnico en anestesia, utilizan tres pabellones de manera simultánea. El informe del hospital comunica que aquella es la práctica habitual. ¿A qué tipo de práctica corresponde este caso?

A) Error médico
B) Impericia
C) Negligencia médica
D) Eficiencia
E) Imprudencia

Respuesta E. Imprudencia médica: En el contexto médico, la imprudencia se define como la realización de acciones temerarias que aumentan innecesariamente el riesgo de complicaciones y problemas para los pacientes. La impericia se refiere a la falta de conocimientos o habilidades necesarios para realizar una actividad o procedimiento médico. La negligencia es la falta del debido cuidado, generalmente por omisió

7.01.3.053 Derecho GES a atención integral de salud en agresión sexual aguda

Dónde se enseña: Tema 21.2 Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos

QUÉ HAY QUE SABER

- La garantía GES de atención integral de la agresión sexual aguda asegura atención oportuna a la víctima, sin depender de la denuncia ni del peritaje.
- Incluye manejo de lesiones, anticoncepción de emergencia, profilaxis de ITS, VIH (idealmente antes de 72 horas) y hepatitis B, toma y custodia de muestras, apoyo psicosocial y seguimiento.
- La atención de salud no se posterga por el peritaje; el establecimiento debe resguardar la cadena de custodia.
- Deber legal del médico de denunciar (24 h) la sospecha de agresión sexual ante Fiscalía, PDI o Carabineros; en menores se protege y se registra textualmente el relato sin interrogatorios repetidos para evitar revictimización.
- La ausencia de lesiones no descarta abuso. Si corresponde (causal 3, Ley 21.030): interrupción hasta 12 semanas, o 14 si es menor de 14 años.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 22 años consulta en un servicio de urgencia 12 horas después de haber sido víctima de una violación con penetración vaginal sin preservativo, por un desconocido. Está hemodinámicamente estable, con lesiones leves. **Según la garantía GES de atención integral en agresión sexual aguda, ¿cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Derivarla al Servicio Médico Legal sin atenderla
> **B)** Atención integral: anticoncepción de emergencia, profilaxis de ITS y VIH, vacuna de hepatitis B, toma de muestras forenses, apoyo psicológico y denuncia
> **C)** Esperar un test de embarazo en 2 semanas antes de indicar anticoncepción
> **D)** Indicar profilaxis de VIH solo si se confirma que el agresor es VIH positivo
> **E)** Indicar solo analgesia y control en atención primaria
> Respuesta B. La garantía GES asegura atención integral oportuna a víctimas de agresión sexual aguda: manejo de lesiones, anticoncepción de emergencia, profilaxis de ITS, VIH (idealmente antes de 72 horas) y hepatitis B, toma y custodia de muestras, apoyo psicosocial y seguimiento. La atención de salud no se posterga por el peritaje, y el establecimiento debe hacer la denuncia.

7.01.3.054 Otorgamiento, uso y sanciones por mal uso de licencias médicas

Dónde se enseña: Tema 21.14 Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Licencia médica: acto médico y documento legal oficial que certifica incapacidad laboral transitoria y justifica la ausencia; origina subsidio. La COMPIN autoriza, reduce o rechaza; la emisión exige evaluación clínica real.
- Tipo 1: enfermedad o accidente común (ej. amigdalitis aguda); tipos 5-6: accidente del trabajo y enfermedad profesional (Ley 16.744), a cargo del organismo administrador (mutualidad o ISL), con notificación DIAT; accidente de trayecto directo es accidente del trabajo.
- Emitir licencia falsa o sin evaluación ni patología que la justifique es delito: presidio, multas de 50 a 500 UTM a beneficio fiscal e inhabilitación temporal o perpetua para emitir licencias y ejercer cargos públicos de salud.
- No se otorga a solicitud del paciente sin justificación clínica; debe constar diagnóstico, reposo y duración.
- Responsabilidad compartida: sanciones también al trabajador que la utilice fraudulentamente.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 5

Se evalúa cuál de las siguientes situaciones corresponde a una licencia médica tipo I, es decir, por enfermedad o accidente común. **¿Cuál de las siguientes corresponde a una licencia médica tipo I?**

A) Amigdalitis aguda
B) Accidente laboral con fractura
C) Enfermedad profesional por ruido
D) Reposo por embarazo de alto riesgo
E) Licencia por maternidad

Respuesta A. La licencia tipo I es por enfermedad o accidente común, es decir, sin relación con el trabajo ni con el embarazo. Una amigdalitis aguda es una enfermedad común corriente. El accidente laboral y la enfermedad profesional se cubren por la ley de accidentes del trabajo, no como tipo I; el embarazo de alto riesgo y la maternidad tienen sus propios regímenes de licencia, distintos del tipo I.

7.01.3.055 Conceptos básicos de administración de establecimientos de salud

Dónde se enseña: sp-15

QUÉ HAY QUE SABER

- Establecimientos de salud: cumplen funciones asistenciales con apoyo administrativo, logístico y técnico; la gestión se organiza por centros de responsabilidad y unidades de apoyo.
- Elementos básicos: planificación anual (programación de actividades y metas), organización por niveles, dirección clínica y administrativa, control y evaluación con indicadores (cobertura, rendimiento, ocupación de camas, promedio de días de estada, giro de camas).
- Calidad y seguridad: acreditación de prestadores institucionales (Superintendencia), autorización sanitaria (SEREMI) y registro de prestadores individuales.
- Gestión de recursos: personal, insumos, infraestructura y financiamiento (per cápita en APS; pago por prestación y por GRD en hospitales).
- Hospitales autogestionados en red con autonomía de gestión; el director es responsable de resultados y cumplimiento de normas.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

El director de un hospital revisa los indicadores de gestión de camas del último trimestre. Quiere conocer qué porcentaje de las camas disponibles estuvo efectivamente ocupado durante el período. **¿Qué indicador debe revisar?**

A) Índice de rotación
B) Promedio de días de estada
C) Índice ocupacional
D) Letalidad hospitalaria
E) Intervalo de sustitución

Respuesta C. El índice ocupacional es días-cama ocupados dividido por días-cama disponibles, por 100. El promedio de días de estada mide cuántos días permanece cada paciente; el índice de rotación, cuántos egresos genera cada cama en el período; y el intervalo de sustitución, el tiempo que una cama queda desocupada entre un egreso y el siguiente ingreso.

7.01.3.056 Conocimiento de los derechos y deberes del paciente

Dónde se enseña: Tema 21.11 Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento · Tema 21.12 Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad

QUÉ HAY QUE SABER

- Ley 20.584: el paciente tiene derecho a trato digno, intimidad y pudor, información clara, consentimiento informado, rechazo de tratamiento, confidencialidad, compañía y facilitador intercultural o lingüístico; también a recibir epicrisis al alta y cuenta financiera clara.
- Ficha clínica: propiedad del paciente; el prestador es custodio y debe conservarla al menos 15 años desde la última atención. Acceso legítimo solo para el paciente, su representante legal, herederos, tribunales y Fiscalía, y Superintendencia; el empleador nunca y la aseguradora solo con poder notarial expreso.
- Prohibido fotografiar o grabar al paciente sin consentimiento informado por escrito, incluso con fines docentes; entregar la ficha a quien no corresponde vulnera el secreto médico (sanción administrativa, civil y penal).

- Menores: consentimiento firmado por representante legal, escuchando al adolescente; en el control del adolescente se entrevista solo con la regla de confidencialidad, salvo riesgo vital propio o ajeno o abuso. Urgencia vital: se actúa sin consentimiento.
- Deberes del paciente: entregar información veraz sobre su salud e identidad, respetar al personal y cumplir las normas del establecimiento.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 46

Se pretende realizar un estudio en adolescentes de dieciséis años, que estudian en colegios del sector público. **¿Quién debe firmar el documento de consentimiento informado para autorizar la participación de estos pacientes?**

A) El alumno
B) El director del establecimiento
C) Cualquier pariente mayor de edad
D) El apoderado
E) El encargado de salud y bienestar estudiantil del establecimiento

Respuesta D. La Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes exige que el consentimiento sea informado y voluntario. En menores de edad, es el representante legal, el apoderado o los padres, quien debe firmarlo, aunque el adolescente tenga derecho a ser escuchado según su edad y madurez. Ni el propio alumno, ni el director, ni un pariente cualquiera sin ese vínculo, ni un funcionario del colegio reemplazan esa representación legal.